

SRH Hochschule Heidelberg
Fakultät für Angewandte Psychologie
Staatlich anerkannte Hochschule

Master-Thesis
zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Science Psychologie

Thema:
**Einfluss der Religiosität auf das psychische Wohlbefinden unter
Berücksichtigung des kulturellen Hintergrundes**

Eingereicht von: Teresa Seidl Fernández
Matrikelnummer: 11013160
Gruppennummer: 63742201

Studiengangsleiter: Prof. Dr. Andrés Steffanowski
Betreuende Dozentin: Fr. Farrenkopf

Heidelberg, den 11. Juli 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Theorie	7
2.1	Konstrukte	7
2.1.1	Religion und Religiosität	7
2.1.1.1	Auswirkung der Religiosität auf die Gesundheit	10
2.1.2	Kultur	12
2.1.2.1	Operationalisierung von Kultur	13
2.1.2.2	Auswirkung der Kultur auf die Gesundheit	15
2.1.3	Wohlbefinden	16
2.1.3.1	Biopsychosoziales Modell	18
2.2	Aktueller Forschungsstand	20
2.2.1	Hypothese 1	20
2.2.2	Hypothese 2	21
2.2.3	Hypothese 3	23
3	Methoden	25
3.1	Stichprobenbeschreibung	25
3.2	Untersuchungsdesign	25
3.3	Operationalisierung der Konstrukte	26
3.4	Untersuchungsdurchführung	28
3.5	Auswertungsmethode	29
4	Ergebnisse	31
4.1	Deskriptive Ergebnisse	31
4.2	Inferenzstatistische Ergebnisse	32
4.2.1	Hypothese 1	32
4.2.2	Hypothese 2	33
4.2.3	Hypothese 3	34
4.3	Explorative Ergebnisse	35

Literaturverzeichnis

37

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1.	<i>Einfache lineare Regression von Religiosität auf psychisches Wohlbefinden</i>	32
Tabelle 2.	<i>Moderationsanalyse Religiosität und kulturelle Orientierung auf das psychische Wohlbefinden</i>	33
Tabelle 3.	<i>Modell mit Haupteffekten</i>	34
Tabelle 4.	<i>Moderationsanalyse Religiosität und biologisches Geschlecht auf das psychische Wohlbefinden</i>	35
Tabelle 5.	<i>Tukey HSD Post-hoc Tests für kulturelle Orientierung nach Religion . .</i>	36

1 Einleitung

In den letzten 120 Jahren hat sich in Europa die religiöse Landschaft verändert. Während im Jahr 1900 noch 99,6% der europäischen Bevölkerung religiös war, hat sich diese Zahl bis 2020 auf 84,4% reduziert (Zurlo, 2021). Gleichzeitig ist in den letzten Jahrzehnten die Prävalenz psychischer Erkrankungen, wie beispielsweise chronischer Depression, gestiegen (European Union, 2021). Dieser Anstieg psychischer Problematiken ist teilweise darauf zurückführbar, dass psychische Erkrankungen heute weniger tabuisiert sind und offener darüber gesprochen wird und somit die Diagnosehäufigkeit ansteigt. Zudem werden diese gegenläufigen Trends die Frage auf, ob und wie Religiosität das psychische Wohlbefinden beeinflusst.

Religion spielt seit jeher eine zentrale Rolle im menschlichen Leben und bietet vielen Menschen nicht nur moralische Orientierung, sondern auch emotionale Unterstützung und sozialen Halt (Hemel, 2023; Jakobs, 2018). Dennoch bildet die Auseinandersetzung mit Religion in der Psychologie bisweilen eine große Lücke (Cohen, 2015). Insbesondere fehlt es an einer umfassenden Betrachtung, die sowohl die positiven als auch die potenziell negativen Auswirkungen von Religiosität auf die psychische Gesundheit in den Blick nimmt.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt, der oft vernachlässigt wird, ist der kulturelle Hintergrund der Individuen. Kultur beeinflusst nicht nur die Art und Weise, wie Religion praktiziert wird, sondern auch, wie Menschen psychisches Wohlbefinden erleben und definieren. Es ist daher notwendig, diese beiden Faktoren – Religiosität und Kultur – in ihrer Wechselwirkung zu betrachten, um ein umfassenderes Verständnis ihrer Auswirkungen auf die psychische Gesundheit zu gewinnen. Hardy, Nelson, Moore und King (2019) beispielsweise betonen, dass die Rolle der Kultur in zukünftigen Forschungen zur Wechselwirkung zwischen Religiosität und psychischem Wohlbefinden mehr Beachtung finden sollte.

Die vorliegende Studie zielt darauf ab, die Religiosität der Befragten, deren Maß an psychischem Wohlbefinden zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Fragebogens sowie ihren kulturellen Hintergrund zu untersuchen. Zu Beginn werden die einzelnen Konstrukte Religion und Religiosität, Kultur und Wohlbefinden erläutert und der theoretische Hintergrund sowie die daraus abgeleiteten Hypothesen vorgestellt. In den darauffolgenden Kapiteln wird auf die Methoden der Studiendurchführung sowie auf die Ergebnisse eingegangen. In der abschließenden Diskussion erfolgt eine umfassende Bewertung der

Ergebnisse sowie ein Ausblick auf den weiteren Forschungsbedarf in diesen Themengebieten.

Diese Studie untersucht die Religiosität der Befragten, deren, zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Fragebogens, Maß an psychischem Wohlbefinden und ihren kultrullen Hintergrund. Zu Beginn werden die einzelnen Konstrukte Religion und Religiosität, Kultur und Wohlbefinden erläutert und der theoretische Hintergrund sowie die daraus abgeleiteten Hypothesen vorgestellt. In den darauffolgenden Kapiteln wird auf die Methoden der Studiendurchführung sowie auch auf die Ergebnisse eingegangen. In der abschließenden Diskussion erfolgt eine umfassende Bewertung der Ergebnisse sowie ein Ausblick auf den weiteren Forschungsbedarf in diesen Themengebieten.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit die Sprachform des generischen Maskulinums verwendet. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

2 Theorie

In diesem Kapitel werden zunächst die verwendeten Konstrukte Religion und Religiosität, psychisches Wohlbefinden und abschließend die Kultur erläutert. Anschließend folgt eine theoretische Herleitung der einzelnen Hypothesen.

2.1 Konstrukte

Im Anschluss erfolgt in den Unterkapiteln eine Einführung in die einzelnen Konstrukte. Beginnend werden in Kapitel 2.1.1 Religion und Religiosität präsentiert und welche Auswirkung Religiosität auf die Gesundheit hat. In Kapitel 2.1.2 wird Kultur, wie sie im Rahmen dieser Studie zu verstehen ist, erklärt, ihre Interaktion mit den anderen beiden Konstrukten aufgezeigt und ihre Auswirkung auf die Gesundheit näher gebracht. Im abschließenden Kapitel 2.1.3 wird erläutert was psychisches Wohlbefinden ist und welche untergeordneten Konstrukten dazu gehören. Des Weiteren stellt es ein Modell, dass die Entstehung und Aufrechterhaltung von Wohlbefinden erklärt, vor.

2.1.1 Religion und Religiosität

Im Rahmen dieser Arbeit wird bei der Darstellung von Religion, ihren Inhalten und Auslegungen sowie der Religiosität ein Schwerpunkt auf Europa und die westliche Welt und das Christentum gelegt. Dennoch werden auch Aspekte anderer Religionen und Regionen der Welt berücksichtigt.

Die Definition von Religion ist in der Wissenschaft umstritten. Einige stellen die Frage, ob der Begriff überhaupt eine stabile Kategorie menschlicher Erfahrung beschreibt (Griffiths, 2000; Monroe et al., 2023). Es gibt jedoch viele Definitionen, die sich auf unterschiedliche Aspekte fokussieren. The Britannica Dictionary (2024) bietet zwei mögliche Definitionen: (a) Religion als Glaube an einen Gott oder eine Gruppe von Göttern; und (b) Religion als ein organisiertes System von Glaubensvorstellungen, Zeremonien und Regeln zur Verehrung eines Gottes oder einer Gruppe von Göttern. Selbst die Etymologie des Wortes Religion hat mehrere Ursprünge, die laut dem Bowker (2003) jedoch auf ein gemeinsames Merkmal hinweisen: Religion hilft Menschen, die Welt zu verstehen und sich im Leben zu orientieren (Schneider & Toyka-Seid, 2024).

Historische Entwicklungen belegen die tiefe Verwurzelung spiritueller Rituale und Überzeugungen in der menschlichen Geschichte. Bereits vor 12.000 Jahren errichteten

frühe Jäger und Sammler beeindruckende Monumente wie Göbekli Tepe, was auf eine weit zurückreichende Glaubenskultur hinweist (Joseph., 2011). Über Jahrtausende hinweg haben Menschen in ihren jeweiligen Regionen verschiedene Religionssysteme entwickelt und in diesen erfolgreich gelebt (Bowker, 2003). Im Jahr 2024 zählen sich etwa 84% der Weltbevölkerung einer Religion zugehörig, unabhängig davon, wie viel oder wenig sie aktiv daran teilnehmen (World Population Review, 2024). Dies verdeutlicht die anhaltende Bedeutung von Religion und Spiritualität für das individuelle und soziale Leben.

Aus soziologischer Sicht haben Religionen schon immer einen erheblichen Wert besessen, da sie als hoch organisiertes Schutzsystem das Überleben und die Selektion fördern. Die Evolutionspsychologie unterstützt diese Sichtweise und zeigt, dass Religion und Spiritualität möglicherweise evolutionäre Vorteile bieten, indem sie durch soziale Bindungen und Vertrauen das Überleben begünstigen. Rituale und religiöse Praktiken können als aufrichtige Signale betrachtet werden, die die Kooperation und den Zusammenhalt innerhalb von Gemeinschaften stärken (Norenzayan & Shariff, 2008). Dies trägt zur Erhöhung des individuellen Wohlbefindens und der sozialen Stabilität bei.

Organisierte Religion umfasst Religionsgemeinschaften mit einem einheitlichen und förmlich festgelegten Glaubenssystem und Ritualen. Das Hauptziel organisierter Religion ist oft die Vereinigung von Menschen. Diese Systeme und Rituale sind durch offizielle Doktrin, hierarchische Führung und Kodifizierung von Verhaltensweisen (Dogmen) festgelegt. Im Gegensatz dazu glauben Anhänger nichtorganisierter Religionen an Gott oder eine höhere Macht, ohne einer organisierten Religion zuzugehören. Sie umfassen moderne Spiritualitätsformen (Köhrsen, 2024).

Religion bezieht sich auf die äußere Beschreibungsebene, während Religiosität das innere Erleben beschreibt (Allolio-Näcke & Demmrich, 2022). Organisierte Religiosität umfasst Praktiken, die in einem sozialen Umfeld gelebt werden, wie der Besuch von Gottesdiensten und die Teilnahme an religiösen Gruppenritualen. Nichtorganisierte Religiosität beinhaltet private Praktiken wie Gebet zu Hause, Meditation und das Hören religiöser Musik (Koenig & Büssing, 2010; Koenig, VanderWeele & Peteet, 2024). Intrinsische Religiosität wird aus innerer Überzeugung heraus gelebt, mit dem Ziel der spirituellen Verbundenheit und persönlichen Wachstum. Extrinsische Religiosität dient als Mittel zum Erreichen weltlicher Ziele wie finanzieller Erfolg oder sozialer Status (Koenig & Büssing, 2010).

Spiritualität ist ein komplexes Konzept, das durch eine wahrgenommene Verbundenheit zum Heiligen oder Transzendenten charakterisiert ist. Sie geht über das

hinaus, was wir sehen oder verstehen können, und beinhaltet existenzielle Fragen wie den Sinn des Lebens (Koenig, 2010). Religion hingegen ist ein System spezifischer Anschauungen und Praktiken, die sich auf heilige Dinge beziehen und oft institutionell organisiert sind (Durkheim, 1981). Die Verbindung von Spiritualität und Religion zeigt sich darin, dass Spiritualität sowohl innerhalb als auch außerhalb von Religion existieren kann (Büssing, 2008).

Wie unterscheiden sich Religion und Spiritualität nun genau? Verschiedene Modelle versuchen zu erklären, wie diese beiden Konzepte miteinander interagieren. Ein Ansatz sieht Spiritualität eng verbunden mit dem Übernatürlichen und Religiösen (Koenig, 2010). Nach dieser Definition ist die Suche nach dem Transzendenten ein Teil der Spiritualität. Ein Nichtgläubiger kann durch Spiritualität zum Hinterfragen, dann zum Glauben und schließlich zur Hingabe gelangen.

Dieses Verständnis von Spiritualität findet sich im traditionellen Modell von Koenig et al. (2024). In diesem Modell ist Spiritualität ein Teil von Religion und Religiosität. Hier dient das Wort *spirituell* zur Beschreibung einer tief religiösen Person. Im moderneren Verständnis hat sich die Bedeutung von Spiritualität jedoch erweitert. Sie umfasst nun sowohl Personen, die sich als religiös bezeichnen, als auch jene, die sich nicht als religiös empfinden, aber trotzdem als spirituell sehen. Diese Veränderung hat zu Herausforderungen bei der Definition und Abgrenzung von Spiritualität geführt. Es ist wichtig, Spiritualität so zu definieren, dass Personen, die sich als spirituell, aber nicht religiös identifizieren, nicht vernachlässigt werden. Letztendlich bleibt es eine Herausforderung, Spiritualität so zu operationalisieren, dass sie beide Gruppen angemessen repräsentiert.

Die Religion gibt vielen Menschen Sinn und Zweck im Leben. Selbst in stark säkularisierten Regionen wie Westeuropa, wie vom Pew Research Center (2022) berichtet, gaben im Median 39% der Befragten an, dass Religion ihnen dieses Gefühl vermittele. Zudem biete sie Trost in Zeiten der Trauer und moralische Orientierung bei schwierigen Entscheidungen. Eine weitere Studie des Pew Research Center (2019) untersuchte, ob Religion eine positive, negative oder gemischte Assoziation mit verschiedenen Indikatoren des individuellen und gesellschaftlichen Wohlbefindens aufweist. Regelmäßige Teilnahme an Aktivitäten einer Religionsgemeinschaft ist in den USA und anderen Ländern mit höherer Zufriedenheit verbunden. Ein Rückgang des religiösen Engagements könnte zu einem Rückgang des individuellen und gesellschaftlichen Wohlbefindens führen (Pew Research Center, 2019).

Schutzsysteme sind essenziell für die Sicherheit und Gewissheit der Menschen,

wodurch sie ihre Interessen und Bedürfnisse verfolgen können. Religionen bieten verschiedene Herangehensweisen, um diese Sicherheit zu gewährleisten, wobei der Fokus je nach Religion und Kultur unterschiedlich ist.

Im Buddhismus liegt der Schwerpunkt auf dem Inneren des Menschen, wobei Achtsamkeit und Meditation zentrale Praktiken sind, um Erleuchtung und inneren Frieden zu erreichen. Ziel ist es, das Potenzial von Körper und Geist zu erkennen und zu entfalten. Andere Religionen betonen das Äußere und die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen sowie die Gemeinschaft mit Gott. Judentum, Christentum und Islam sind Beispiele für Religionen, die göttliche Unterstützung betonen und das Böse definieren. Sie untersuchen die Qualität der Beziehung zu sich selbst, zu Mitmenschen und zu Gott.

Religionen vermitteln wichtige Lehren und dienen als moralischer Kompass, indem sie sowohl nach innen als auch nach außen gerichtete Ansätze berücksichtigen, mit unterschiedlichem primären Fokus. Somit fungieren sie als Schutzsysteme, die wesentliche Aspekte des menschlichen Lebens und Wohlbefindens bewahren. Insgesamt bieten Religionen nicht nur spirituelle Orientierung, sondern unterstützen auch das menschliche Leben in seiner gesamten Komplexität (Bowker, 2003).

2.1.1.1 Auswirkung der Religiosität auf die Gesundheit

Religionen basieren auf einer eigenen, spezifischen religiösen Logik und beschäftigen sich mit grundlegenden, aber nicht abschließend beantworteten Fragen. Diese umfassen Themen wie die Stellung des Menschen in der Welt, was nach dem Tod geschieht und die Definition eines „guten Lebens“ sowie moralische Pflichten gemäß den Werten der spezifischen Religionsgemeinschaft. Aufgrund dessen haben Religionen einen erheblichen Einfluss auf Erziehung, Bildung, Handeln und auch auf die Gesundheit und gesundheitsrelevantes Verhalten. Sie bieten ihren Anhängern eine umfassende Weltanschauung, die durch ein komplexes System von Symbolen, Geschichten und Lehren geprägt ist. Diese Symbole und Geschichten dienen als Mittel, um tiefgehende Fragen des Lebens, die Natur des Göttlichen und die moralischen Prinzipien zu verstehen. Durch diese symbolische Deutung der Welt gewinnen die Gläubigen eine klare Perspektive und ein tieferes Verständnis ihrer Existenz. Zusätzlich umfassen sie eine Vielzahl spezifischer religiöser Praktiken, die darauf abzielen, den Menschen Orientierung, Sinn und Halt im Leben zu geben. Diese Symbole und Geschichten, die oft als eine lebensprägende Erzählung oder Narration dienen, haben häufig eine direkte Bedeutung für den Alltag der

Gläubigen und beeinflussen ihr Verhalten sowie ihre Entscheidungen. Dazu gehören Vorstellungen von der „richtigen“ sozialen Ordnung, Anstand und Moral, Machtverhältnissen und Ohnmacht sowie Selbst- und Weltbilder. Zudem prägen Religionen auch körper- und geschlechtsbezogene Rollenbilder sowie Ansichten zu Ernährung und Sexualität (Hemel, 2023).

Die Beziehung zwischen Religiosität und Gesundheit ist jedoch komplex und ambivalent. Es gibt sowohl positive als auch negative Auswirkungen, die in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert werden. Unumstritten ist, dass schon bevor der Mensch Psychosomatik als solche definierte, in religiösen Weltansichten die körperliche und seelische Gesundheit als verbunden betrachtet wurde und wird. Sowohl Hemel (2023) als auch Jakobs (2018) betonen, dass Religiosität positive Effekte wie die Förderung sozialer Unterstützung, Gemeinschaft und Sinnstiftung hat. Diese soziale Unterstützung wiederum hat positive Effekte auf die Gesundheit. Außerdem verstärkt Religiosität die emotionale und behaviorale Selbstregulation, was zu einem besseren Gesundheitsverhalten und günstigeren physiologischen Prozessen führt. Diese Effekte tragen dazu bei, die Häufigkeit von Erkrankungen zu reduzieren und die Mortalität zu senken. Religiöse Überzeugungen können Menschen helfen, Krisen zu bewältigen und dem Leben einen tieferen Sinn zu geben. Andererseits können strikte religiöse Normen zu Schuldgefühlen und Angst führen, und extreme religiöse Praktiken können soziale Isolation und psychische Belastungen verursachen (Krause, 2015).

Hemel (2023) hebt hervor, dass soziokulturelle Praktiken, die durch Religion vermittelt werden, insbesondere bei Frauen Schutz und Unterstützung bieten können, aber auch restriktive Normen und Rollenbilder die Autonomie und das Wohlbefinden beeinträchtigen können.

Jakobs (2018) konzentriert sich auf die individuelle religiöse Erfahrung und deren Bedeutung für die allgemeine psychische Gesundheit. Er unterstreicht, dass eine positive Religionspädagogik die positiven Effekte der Religiosität verstärken kann. Zusätzliche spezifische negative Effekte gegenüber den allgemeinen Aussagen führt Jakobs nicht an.

Krause (2015) beschreibt, dass das Gebet als häufige Form der spirituellen Praxis sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben kann. Positive Auswirkungen umfassen die Förderung von Wohlbefinden und die Reduktion von Stress. Negative Auswirkungen können auftreten, wenn Gebete von Angst und Hader geprägt sind oder wenn sie als einzige Bewältigungsstrategie verwendet werden, ohne andere unterstützende Maßnahmen zu ergreifen. Studien zeigen, dass religiöse Praktiken

das Auftreten von Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Infarkten und Schmerzen verringern und das Langzeitüberleben fördern können. Hoffnung ist ein wichtiger Faktor für das psychische Wohlbefinden und wirkt als Puffer gegen psychische Erkrankungen. Sie hängt mit einem höheren Selbstwertgefühl, mehr positiven Gefühlen und einem besseren subjektiven Wohlbefinden zusammen. In Zeiten von Krankheit und Krisen stellt Hoffnung eine wertvolle Ressource dar (Krause, 2015).

2.1.2 Kultur

Was ist Kultur? Bowker (2003) beschreibt es als zweite Schutzhaut des Replikationsprozesses. Wir Menschen sind als Lebewesen darauf ausgerichtet, unsere Spezies am Leben zu erhalten. Jene mit guten Genen überleben besser und pflanzen sich vermehrt fort als solche mit nachteiligen Genen. In seiner Erklärung, was Kultur ist, beschreibt Bowker (2003) unsere Haut als den ersten Schutzmechanismus für den Genreplikationsprozess. Da wir jedoch soziale und intelligente Wesen sind, haben wir ein weiteres Verteidigungssystem implementiert, das sich außerhalb der Grenzen unseres Körpers befindet; die gemeinsamen kulturellen Errungenschaften. Die Kultur schützt uns demzufolge vor dem Aussterben. Religionen haben sich in den vielen, damals stark voneinander getrennte Kulturen sehr früh als System entwickelt, um die Gruppe zu erhalten. Wie lassen sich Religion und Kultur voneinander trennen? Es ist wichtig festzuhalten, dass sie sich gegenseitig beeinflussen können und dies auch tun. Stark säkulare¹ Länder und Kulturen lassen durch ihre säkularen Institutionen und Angebote Religion weniger notwendig erscheinen (Cohen, 2015). So, wie Durkheim (1915) Religion definiert, ist sie von der Kultur nicht zu trennen, da ihre Überzeugungen und Praktiken kulturell geprägt sind. Vor vielen Jahrhunderten diktierten die Religionsoberhäupter in Europa die Politik, was zeigt, wie eng kulturelle Institutionen und politische Macht verflochten waren. Kultur prägt politische Werte und Normen, während Politik kulturelle Identitäten nutzt, um Herrschaft zu legitimieren und soziale Ordnung zu schaffen. Noch heute ist dies in anderen Regionen der Welt noch der Fall, wie beispielsweise in Indien oder dem Iran. Von diesem Standpunkt aus ist es nachvollziehbar, dass Kultur und Religion sehr eng miteinander verwoben sind. Die enge Verknüpfung zwischen Kultur und Religion ist nicht spezifisch auf eine Denomination beschränkt. Im Christentum sowie im Buddhismus und den anderen Weltreligionen prägen die religiösen Philosophie die Kultur

¹Trennung von Kirche und Staat

und umgekehrt (Croucher, Zeng, Rahmani & Sommer, 2017). Doch gilt dieser Grundsatz noch immer? In Europa beispielsweise schreitet die Säkularisierung immer weiter voran. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stieg dort die Individualisierung der Gesellschaft an und zugleich verloren jüdisch-christliche Institutionen ihre Autorität. Dies hat jedoch der Religion nicht die wichtige Rolle entzogen, in schwierigen und schmerzhaften Zeiten eine Quelle der Kraft und des Haltes zu sein (Croucher et al., 2017). Obwohl Religion und Kultur interagieren, heißt es nicht, dass sie das Gleiche abbilden, oder das Gleiche aussagen. In multikulturellen und multireligiösen Staaten oder Regionen umfasst keine Religion die gesamte Gesellschaft, und diese richtet sich nicht ausschließlich nach religiösen Vorschriften und Praktiken. Es ist sinnvoll, die beiden Sphären als miteinander verbunden zu betrachten und ihre Wechselwirkungen zu analysieren (McGlichey, Waters & Scheinpflug, 2023).

2.1.2.1 Operationalisierung von Kultur

Wenn Kultur und Religion nicht voneinander trennbar sind, wie lässt sich dann Kultur beobachten? Hofstede (2001) entwickelte sechs Kulturdimensionen, mit denen sich unterschiedliche Kulturen vergleichen und beschreiben lassen. Dafür definierte er Kultur vereinfacht als „Software des Geistes“ (Hofstede, 2001, S. 209). Laut ihm setzt sich eine Kultur aus diesen nachfolgenden sechs Dimensionen zusammen und ermöglicht es, Kulturen zu vergleichen.

Die *Machtdistanz* beschreibt die Akzeptanz der Machtverteilung. In Kulturen mit hoher Machtdistanz werden starke Hierarchien akzeptiert, in denen beispielsweise Führungskräfte Entscheidungen treffen, die nicht in Frage gestellt werden. Im Gegensatz dazu zeichnen sich Kulturen mit einer niedrigen Machtdistanz durch flache Hierarchien aus, in denen Menschen eher auf gleicher Augenhöhe miteinander interagieren (Knecht, 2020).

Die zweite Dimension, der *Individualismus* beschreibt die Stärke der zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb einer Kultur. In individualistisch geprägten Gesellschaften sind diese Bindungen eher locker, wobei das Individuum im Mittelpunkt steht. Im Gegensatz dazu steht in kollektivistischen Kulturen das Kollektiv im Vordergrund, wobei Loyalität, Fürsorge und Harmonie wichtige Merkmale sind (Knecht, 2020).

Maskulinität stellt die dritte Dimension da und beschreibt das Ausmaß, in dem

eine Kultur die traditionelle Aufteilung der Geschlechterrollen akzeptiert. In maskulinen Gesellschaften sind diese Rollen klar definiert, während in femininen Kulturen die Rollen flexibler sein können. Darüber hinaus zeichnen sich maskuline Kulturen durch Betonung von Status, Macht und Prestige aus, während feminine Kulturen eher von Fürsorge und Empathie geprägt sind (Knecht, 2020).

Die *Unsicherheitsvermeidung* beschreibt das Ausmaß, in dem eine Gesellschaft Risiken scheut und sich gegenüber Veränderungen und Innovationen zurückhaltend verhält. Kulturen mit hoher Unsicherheitsvermeidung bevorzugen bewährte Muster und versuchen, Unsicherheiten durch Regeln und Vorschriften zu minimieren (Knecht, 2020).

Die fünfte Dimension *Langzeitorientierung* beschreibt, ob eine Kultur dazu neigt, langfristige Ziele zu planen und zu verfolgen oder eher spontan und kurzfristig handelt und denkt (Knecht, 2020).

Die sechste und letzte Dimension, der *Genuss*, zeigt an, inwieweit eine Kultur die Selbstverwirklichung jedes Einzelnen akzeptiert. In Kulturen mit hoher Indulgenz werden auch Randgruppen oder Menschen, die nicht dem Mainstream entsprechen, akzeptiert und die Freiheit wird als wichtiger Wert angesehen. In Kulturen mit niedriger Indulgenz sind die Regeln und Normen hingegen strikter (Knecht, 2020).

Wilczewski et al. (2023) und weitere nutzen die Individualismus-Kollektivismus Dimension um Kulturen in wissenschaftlichen Studien zu vergleichen. Wie bereits in der kurzen Beschreibung der Dimension geschildert, bildet sie die Beziehung des Individuums zur Gesellschaft ab. Steht das Individuum in einer engen Beziehung zu anderen entspricht dies dem Kollektivismus. Ist die Beziehung zwischen Individuum und anderen Gesellschaftsmitgliedern loser, dann entspricht dies dem Individualismus (Hofstede, 2001). Individualismus bedeutet aber nicht Egoismus, sondern vielmehr, dass das Individuum eigene Entscheidungen trifft (Hofstede, 2024). Ein Beispiel dafür sind die USA, in denen die Unabhängigkeit und Autonomie des Individuums wertgeschätzt werden (Utler, 2020). Auf der anderen Seite bedeutet Kollektivismus nicht Verbundenheit. Es ist viel mehr, dass jede Personen ihren Platz im Leben kennt, der durch die Gesellschaft bestimmt wird (Hofstede, 2024). China oder Pakistan sind Beispiele dafür, da hier das Individuum seine eigenen Ziele wie Arbeit oder Familie hinter die Ziele der sozialen Gruppe stellt. Da dies für alle Mitglieder der Gesellschaft gilt, erhalten sie von ihr bedingungslose Unterstützung und Schutz. Auf familiärer Ebene steht die Kernfamilie aus Mutter, Vater, Kind für individualistische und die Großfamilie für kollektivistische Gesellschaften (Utler, 2020).

2.1.2.2 Auswirkung der Kultur auf die Gesundheit

Die Bedeutung und das Verständnis von Gesundheit, Krankheit und Wohlbefinden sind kulturell geprägt. Dies umfasst, wie Menschen ihre Gesundheit einschätzen, wie sie Symptome interpretieren und wie sie mit gesundheitlichen Herausforderungen umgehen. Diese Verhaltensweisen werden durch kulturelle Normen und Überzeugungen geprägt (Hernandez & Gibb, 2019; Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa, 2024). Die Kultur beeinflusst die Einstellungen, die Personen zu den verfügbaren Gesundheitsmaßnahmen wie Impfprogrammen oder Psychotherapie haben, wie sie auf solche Maßnahmen reagieren und kann somit den Erfolg oder das Scheitern dieser Interventionen bestimmen (Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa, 2024).

In vielen Kulturen werden psychische Leiden häufig stigmatisiert oder als körperliche Beschwerden interpretiert, was zu Verzögerungen bei der Suche nach professioneller Hilfe führen kann. Beispielsweise neigen kollektivistische Kulturen wie China dazu, psychische Probleme zu verschweigen, was zu einer Unterbehandlung führen kann (Hernandez & Gibb, 2019). Da dem Individuum weniger Bedeutung beigemessen wird als beispielsweise der Familie, werden psychische Erkrankungen als Scheitern der Gruppe gesehen. Um das Ansehen der Familie nicht zu beschädigen, werden die Erkrankungen und Beschwerden oft verheimlicht (Karasz et al., 2019).

Auch für die Einrichtung von Gesundheitsdiensten und den Zugang zu diesen spielen kulturelle Prägungen eine große Rolle. Sie beeinflussen, welche Gesundheitsdienste in Anspruch genommen werden und wie diese genutzt werden (Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa, 2024). So wird im südostasiatischen Raum der Fokus eher auf das Wohl der Gemeinschaft gelegt als auf das Individuum, was sich auf die Gesundheitspraktiken und die Interaktion mit dem Gesundheitssystem auswirkt. In muslimischen Gesellschaften kann die Tabuisierung bestimmter Gesundheitsthemen die Gesundheitskompetenz und die Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten negativ beeinflussen (Wielga & Knospe, 2023).

Allerdings kann die Kultur einer Gemeinschaft deren Widerstandsfähigkeit stärken und zu einem besseren Wohlbefinden beitragen (Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa, 2024). Des Weiteren können durch kulturelle Praktiken die Bindung zur Gemeinschaft gefördert werden. Gemeinschaften, die durch gemeinsame kulturelle Traditionen verbunden sind, bieten ihren Mitgliedern ein Gefühl der Zugehörigkeit und emotionaler Unterstützung. Die Gemeinschaft kann in Zeiten von Stress oder Krankheit soziale Unterstützung bieten, was die psychische Gesundheit

schützt und stärkt. So konnte beispielsweise beobachtet werden, dass aufgrund der Begräbnisrituale des Stammes der Acholi in Uganda die Verbreitung von Ebola begrenzt werden kann, während diese Krankheiten sich in angrenzenden Gebieten ohne diesen Ritualen stärker verbreiteten. (Hewlett & Hewlett, 2008).

2.1.3 Wohlbefinden

Die World Health Organization (1948) definiert „Gesundheit als einen Zustand vollkommenem körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens“ (S. 01). In Anlehnung an diese Definition hat der Begriff des Wohlbefindens zahlreiche Präzisierungsversuche durch verschiedene Disziplinen erfahren. Gesundheit und Wohlbefinden werden oft undifferenziert in einem Atemzug genannt. Trojan und Legewie (2001) argumentieren jedoch, dass Wohlbefinden im Unterschied zur Gesundheit einen äußerst komplexen subjektiven Bewusstseinszustand darstellt, der sich grundsätzlich einer direkten äußeren Beobachtung entzieht. Diese subjektive Dimension wird auch in der Beschreibung von Mayring (1991) deutlich, demzufolge Wohlbefinden durch vier Faktoren charakterisiert wird. Diese sind (a) die *Freiheit von Belastungen* im Sinne einer Abwesenheit subjektiver Belastungen, Krankheitssymptomen und negativer Gefühle; (b) das *Erleben von Freude im Alltag*, ausgedrückt durch kurzfristige positive Gefühle; (c) die *Zufriedenheit*, die aus dem Abwägen positiver und negativer Lebensaspekte resultiert; und (d) das *Empfinden von Glück*, das über den konkreten Moment hinausgeht und mit einem insgesamt positiven Lebensgefühl verbunden ist. Der subjektive Gesundheitszustand dient auch als verlässliches Indiz für die objektive gesundheitliche Lage (Hornberg, 2016).

Die Definition des mehrdimensionalen Wohlbefindens ist komplex und interdisziplinär. Wissenschaftler im Bereich der Psychologie, Philosophie und Sozialwissenschaften haben verschiedene Definitionen aufgestellt, die im Kern jedoch auf einen gemeinsamen Nenner treffen. Wohlbefinden umfasst subjektive und objektive Dimensionen und beinhaltet sowohl individuelle Erfahrungen als auch den Vergleich der Lebensumstände mit sozialen Normen und Werten (Dhanabhakym & Sarath, 2023; Röhrle, 2023). Das vielschichtige Konstrukt umfasst emotionale, psychologische und soziale Dimensionen. Es beinhaltet positive Emotionen (wie Glück und Zufriedenheit), das Fehlen negativer Emotionen (wie Depression und Angst), eine hohe Lebenszufriedenheit und einen Zweck im Leben, Erfüllung und positives Funktionieren und Autonomie sowie positive Beziehungen und persönliches Wachstum (Dhanabhakym & Sarath, 2023;

Sischka, Costa, Steffgen & Schmidt, 2020a). Es schließt sowohl affektive Komponenten (positive und negative Gefühle) als auch kognitive Bewertungen (Lebenszufriedenheit) ein (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999; Nelson, Kushlev & Lyubomirsky, 2014). In der Psychologie wird Wohlbefinden allgemein als ein positiver und wünschenswerter Zustand betrachtet, im Gegensatz zu Unwohlsein, das als negativ und unerwünscht gilt (Lucas, 2016).

Positives emotionales Befinden gilt als Überbegriff für das subjektiv empfundene Wohlbefinden. Freude und Glück, die oft in Verbindung mit Wohlbefinden gebracht werden, sind verschiedene Erscheinungsformen dessen. Dabei wird zwischen aktuellen, situationsspezifischen emotionalen Zuständen *States* und langandauernden, übergreifenden emotionalen Zuständen als Persönlichkeitseigenschaften *Traits* differenziert. Freude wird als State verstanden (Mayring, 1991). Es ist ein emotionaler Zustand, der früh in der menschlichen Entwicklung auftritt. Durch soziale Interaktionen wird diese vertieft. Dieser Zustand ist gekennzeichnet durch Selbstvertrauen, Anerkennung, Zufriedenheit, Sicherheit und das Gefühl, geliebt zu werden (Izard, 1994). Glück hingegen besitzt sowohl eine State- als auch als Trait-Komponente. Auch Glück wird durch mehrere Faktoren beeinflusst. Hoffmann (1984) identifiziert unter anderem die Qualität menschlicher Beziehungen, schöpferische Kraft, Öffnung der Sinne, Erotik, Ruhe und Entspannung sowie die Bejahung von Leben und Sinnhaftigkeit des Lebens als wichtige Komponenten. Glück wird vielmehr als Trait verstanden, das über den Lebenslauf aufgebaut wird (Mayring, 1991).

In dieser Arbeit wird die subjektive Dimension des Wohlbefindens betrachtet. Das subjektive Wohlbefinden (SWB) ist ein umfassender Begriff, der sowohl emotionale Reaktionen, Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen als auch allumfassende Lebenszufriedenheit umfasst. Dabei handelt es sich um eine weit gefasste Kategorie von Phänomenen, die die emotionalen Reaktionen der Menschen, die Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensbereichen und die globalen Urteile über die Lebenszufriedenheit einschließt (Diener et al., 1999). Es wird stark mit der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (2000) verknüpft, die drei zentrale menschliche Grundbedürfnisse betont: Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Diese Bedürfnisse sind entscheidend für das Wohlbefinden, da ihre Befriedigung zu einem tiefen Gefühl von Vitalität, psychischer Gesundheit und Lebenszufriedenheit führt (Deci & Ryan, 2000; Ng et al., 2012). Davon wird von manchen Autoren das psychische Wohlbefinden (PWB) unterschieden. Es beinhaltet die allgemeine psychische Gesundheit und emotionale Stabilität, einschließlich der Abwesenheit von psychischen Störungen wie Depression und

Angst. Aber auch positive psychologische Funktionen wie Selbstakzeptanz, Sinnhaftigkeit, persönliches Wachstum und Autonomie gehören dazu. Das PWB wird auch im Kontext von SWB als Teilmenge betrachtet, das es die allgemeine psychische Gesundheit und emotionale Stabilität umfasst. PWB kann als eine Dimension des SWB gesehen werden, da es stark auf den emotionalen und kognitiven Bewertungen des Individuums basiert (Maly-Motta, 2023). In der psychologischen Literatur werden SWB und PWB oft synonym verwendet, insbesondere wenn es darum geht, das allgemeine Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit zu bewerten. Beide Begriffe beziehen sich auf die persönliche Bewertung des eigenen Lebens und die Emotionen, die mit diesen Bewertungen verbunden sind (Diener et al., 1999). Das et al. (2020) diskutieren verschiedene Theorien des SWB, die von psychologischen Mechanismen beeinflusst werden. Diese Theorien betonen, wie sowohl interne als auch externe Faktoren das individuelle SWB beeinflussen, und integrieren Konzepte wie persönliches Wachstum, Zielerreichung und emotionale Zustände als wesentliche Bestandteile des PWB. Diener, Oishi und Lucas (2009) behandeln SWB umfassend und beschreiben es als kognitive und affektive Bewertungen des Lebens einer Person. Es wird oft in Verbindung mit Konzepten wie Lebenszufriedenheit und emotionalen Reaktionen auf Lebensereignisse untersucht, was zeigt, dass SWB und PWB häufig gleichgesetzt werden verwendet werden.

2.1.3.1 Biopsychosoziales Modell

Das biopsychosoziale Modell, entwickelt von Engel (1977) in den 1970er Jahren, bietet einen umfassenden Rahmen zur Erklärung der Entstehung und Aufrechterhaltung von Gesundheit und Krankheit. Es integriert biologische, psychologische und soziale Faktoren und betont deren wechselseitige Beeinflussung. Während biologische Aspekte die genetischen, neurobiologischen und physiologischen Grundlagen umfassen, beinhalten psychologische Faktoren Kognition, Emotion und Verhalten. Soziale Einflüsse beziehen sich auf soziale Netzwerke, kulturelle Werte und gesellschaftliche Strukturen. Diese ganzheitliche Perspektive ermöglicht es, komplexe Gesundheitsprobleme besser zu verstehen (Borrell-Carrió, Suchman & Epstein, 2004).

Biologische Einflüsse: Wohlbefinden hat einen inneren und instrumentellen Wert und ist integraler Bestandteil der Gesundheit. Biologische Faktoren spielen eine entscheidende Rolle für das psychische Wohlbefinden. Genetische Veranlagungen, neurobiologische Mechanismen, Hormonspiegel und körperliche Gesundheit beeinflussen,

wie Menschen auf Stress und Lebensereignisse reagieren. Beispielsweise können chronische Krankheiten, hormonelle Ungleichgewichte oder neurochemische Dysfunktionen das Wohlbefinden beeinträchtigen und zu psychischen Gesundheitsproblemen führen (Kiecolt-Glaser, McGuire, Robles & Glaser, 2002; Sapolsky, 2004).

Psychologische Einflüsse: Psychologische Faktoren wie individuelle Bewältigungsstrategien, Selbstwirksamkeit und emotionale Intelligenz beeinflussen ebenfalls das Wohlbefinden. Resilienz spielt eine wichtige Rolle, obwohl Menschen, die widrigen Umständen ausgesetzt sind, einem höheren Risiko für psychische Gesundheitsprobleme ausgesetzt sind. Die Fähigkeit, mit Stress umzugehen und sich von Rückschlägen zu erholen, hängt stark von den kognitiven und emotionalen Ressourcen ab, die eine Person mobilisieren kann (Bandura, 1997; Carver, 2010).

Soziale Einflüsse: Äußere Anforderungen und kritische Lebensereignisse können das Wohlbefinden beeinträchtigen. Die subjektive Wahrnehmung und Bewertung dieser Ereignisse spielen eine entscheidende Rolle für das individuelle Wohlbefinden. Stressoren, die als bedrohlich oder belastend wahrgenommen werden, können zu einer Verschlechterung des subjektiven Wohlbefindens führen, was sich in physischen und psychischen Gesundheitsproblemen manifestieren kann. Darüber hinaus sind soziale Unterstützung und stabile Beziehungen wichtige Ressourcen, die das Wohlbefinden stärken und die Resilienz gegenüber Stress erhöhen können (Lazarus & Folkman, 1987; Pearlin, 2010; Uchino, 2006). Kultur und Religiosität sind wesentliche soziale Faktoren, die das Wohlbefinden beeinflussen können. Diese Elemente spielen eine Rolle in der Art und Weise, wie Menschen Stress wahrnehmen und bewältigen, welche Bewältigungsstrategien sie entwickeln und wie sie soziale Unterstützung suchen und erhalten (Matsumoto & Juang, 2016).

Kulturelle Werte und Normen prägen das Verständnis von Wohlbefinden und Gesundheit. Unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Auffassungen darüber, was es bedeutet, psychisch gesund zu sein, und welche Verhaltensweisen als gesundheitsfördernd gelten. Kulturelle Hintergründe beeinflussen auch die soziale Unterstützung, die Menschen erhalten, sowie die Stigmatisierung von psychischen Gesundheitsproblemen (Triandis, 1994). Wie bereits in Kapitel 2.1.1.1 aufgeführt, kann Religiosität als Ressource für das Wohlbefinden dienen, indem sie den Menschen einen Sinn im Leben gibt, soziale Unterstützung bieten und Bewältigungsstrategien fördert. Religionsgemeinschaften können soziale Netzwerke bereitstellen, die emotionale Unterstützung bieten und das Gefühl der Zugehörigkeit stärken. Darüber hinaus können religiöse Praktiken wie Gebet oder

Meditation stressmindernd wirken und das psychische Wohlbefinden fördern (Koenig, 2012; Pargament, 1997).

2.2 Aktueller Forschungsstand

In dieser Studie wird folgende Frage untersucht: Hat der Einfluss der Religiosität auf das psychische Wohlbefinden einen kulturellen Unterschied?

In den folgenden drei Unterkapiteln 2.2.1 Hypothese 1, 2.2.2 Hypothese 2 und 2.2.3 Hypothese 3 erfolgt die Herleitung der zu untersuchenden Hypothesen auf Basis bereits bestehender Befunde.

2.2.1 Hypothese 1

Religiosität und Wohlbefinden sind zwei Konzepte, die in der psychologischen Forschung häufig untersucht wurden. Es gibt zahlreiche Studien, die einen positiven Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Dimensionen von Religiosität und verschiedenen Aspekten des Wohlbefindens belegen. Diese Beziehung wird oft auf Faktoren wie soziale Unterstützung, Sinnfindung im Leben und Bewältigungsmechanismen zurückgeführt, die mit religiösen Praktiken und Überzeugungen einhergehen.

Die erste Hypothese überprüft, ob das religiöse Engagement und religiöse Aktivitäten positiv mit Wohlbefinden korrelieren. Diese Aussage wird durch bereits bestehende Ergebnisse unterstützt. Eine Studie von Dar und Iqbal (2019) zeigte eine positive Assoziation zwischen religiösem Engagement und verschiedenen Aspekten des Wohlbefindens, einschließlich Lebenszufriedenheit, Glück und Optimismus (vgl. Kapitel 2.1.3). Der totale Effekt von Religiosität auf das Wohlbefinden betrug $B = .39$ ($p < .001$) und der direkte Effekt einen Wert von $B = .28$ ($p < .050$). Dies zeigt, dass ein Teil des Einflusses von Religiosität auf das Wohlbefinden ohne andere Faktoren besteht. Auch bivariate Analysen von Koenig und Al Shohaib (2024) zeigen eine positive Assoziation zwischen Gesamt-Religiosität und Lebenszufriedenheit ($r = .12$), Glück ($r = .13$) und Optimismus ($r = .19$), was als kleiner bis mittlerer Effekt bewertet wird. Multivariate Analysen bestätigten diese Ergebnisse und zeigen signifikante Beziehungen zwischen Gesamt-Religiosität und Lebenszufriedenheit ($B = .046$, $SE = 0.005$), Glück ($OR = 1.03$, 95% CI [1.02, 1.04]) und Optimismus ($B = .054$, $SE = 0.005$), wobei ebenfalls kleine bis mittlere Effekte nachgewiesen wurden.

Van Cappellen, Toth-Gauthier, Saroglou und Fredrickson (2016) wiesen auf, dass

allgemeine Religiösität in einer positiven Beziehung zum Wohlbefinden ($B = .11$, $SE = .03$, $p < .010$) steht. Auch die häufige Teilnahme an religiösen Aktivitäten scheint mit höheren Werten des Wohlbefindens zusammenzuhängen. Jokela (2022) wies eine moderate positive Korrelation zwischen psychischen Wohlbefinden und religiöser Teilnahme ($B = 0.29$; 95% CI [0.14, 0.45]) sowie allgemeiner Religiosität ($B = 0.37$; CI [0.21, 0.53]) auf. Des Weiteren zeigen seine Ergebnisse eine moderate negative Korrelation mit psychischem Stress auf ($B = -0.11$; CI [-0.16, -0.06] für Religiosität und $B = -0.14$; CI [-0.19, -0.09] für religiöse Teilnahme), die sich wiederum auf die psychische Gesundheit und damit auf das Wohlbefinden auswirken. In dieser Studie wurden zudem monotone Assoziationen zwischen religiöser Teilnahme und psychischem Stress sowie Wohlbefinden festgestellt. Dies bedeutet, dass mit zunehmender religiöser Teilnahme sowohl der psychische Stress abnimmt als auch das psychische Wohlbefinden steigt. Ebenso gab es monotone Assoziationen zwischen Religiosität und psychischem Wohlbefinden (Jokela, 2022). So wie psychischer Stress haben depressive und ängstliche Symptomatik einen negativen Einfluss auf das psychische Wohlbefinden. Fernández und Rosell (2022) untersuchten dessen Zusammenhang mit Religiosität im Sinne von organisierter Religiosität und intrinsischer Religiosität. Die Ergebnisse zeigen eine negative Assoziation von organisierter Religiosität mit depressiver Symptomatik ($\beta = -.08$; $p = .001$). Die intrinsische Religiosität korreliert ebenfalls negativ mit ängstlicher Symptomatik ($\beta = -.07$; $p = .002$). Diese Effekte sind zwar klein, aber signifikant.

2.2.2 Hypothese 2

Die Forschung zeigt, dass Wohlbefinden positiv mit Religiosität zusammenhängt. Solche Beziehungen treten zudem in verschiedenen Kulturen auf, in denen Menschen unterschiedlichen Glaubensrichtungen folgen (Graham & Crown, 2014; Tay, Li, Myers & Diener, 2014). Der Einfluss der Kultur auf die Beziehung zwischen der Religiosität und dem Wohlbefinden sind Bestandteil der zweiten Hypothese.

In kollektivistischen Kulturen, die stärker auf Familiennetzwerke und gemeinschaftliche Bindungen fokussiert sind, könnte der Einfluss von intrinsischer Religiosität auf das Wohlbefinden durch das Familiennetzwerk besonders stark ausgeprägt sein. Die signifikanten indirekten Effekte durch das Familiennetzwerk ($\beta = -0.012$ für depressive Symptomatik und $\beta = -0.005$ für ängstliche Symptomatik) unterstützen diese Annahme. In individualistischen Kulturen, in denen persönliche Freundschaften und

individuelle Netzwerke eine größere Rolle spielen, könnte der Einfluss von organisierter Religiosität auf das Wohlbefinden durch Freundesnetzwerke stärker ausgeprägt sein. Die signifikanten indirekten Effekte durch das Freundesnetzwerk ($\beta = -0.007$ für depressive Symptomatik und $\beta = -0.002$ für ängstliche Symptomatik) deuten darauf hin, dass Freundschaften in diesen Kulturen eine wichtige Rolle spielen. Diese Mediationseffekte legen nahe, dass Kultur einen moderierenden Effekt auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden haben könnte. In kollektivistischen Kulturen könnte intrinsische Religiosität über starke Familiennetzwerke einen größeren positiven Einfluss auf das Wohlbefinden haben, während in individualistischen Kulturen organisierte Religiosität über Freundesnetzwerke eine wichtigere Rolle spielen könnte. Diese Spekulationen könnten in zukünftigen Studien weiter untersucht werden, um den Einfluss der Kultur auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden genauer zu verstehen. (Fernández & Rosell, 2022)

In der Studie von Hoogeveen et al. (2022) wurde der Einfluss kultureller Normen auf die Beziehung zwischen Religiosität und selbstberichteter Lebenszufriedenheit untersucht. Von 101 Teams berichteten 97 positive Beta-Koeffizienten, wobei 65% der Konfidenzintervalle den Wert Null ausschlossen. Der Median der Effektgröße betrug .039, was einem kleinen, aber positiven Effekt entspricht. Die Median Absolute Deviation von 0.022 weist darauf hin, dass die Streuung der Effektgrößen relativ gering ist, was die Zuverlässigkeit der Ergebnisse weiter unterstützt. Zudem kamen 54% der Teams zu dem Schluss, dass kulturelle Normen einen signifikanten Einfluss haben. Insbesondere die Tatsache, dass der Median der berichteten Effektgrößen positiv ist und dass ein signifikanter Anteil der Konfidenzintervalle den Wert Null ausschließt, unterstützt die Annahme, dass kulturelle Normen einen moderierenden Effekt haben. Diese Erkenntnisse können genutzt werden, um zu argumentieren, dass kulturelle Unterschiede, wie sie in der Dimension Individualismus-Kollektivismus definiert sind, ebenfalls einen solchen moderierenden Effekt haben könnten.

Diese Ergebnisse können für die Untersuchung der Hypothese, dass Kultur einen Einfluss auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden hat, besonders im Hinblick auf die Unterscheidung von Kulturen auf der Dimension Individualismus-Kollektivismus, herangezogen werden. Die in der Studie von Fernández und Rosell (2022) und Hoogeveen et al. (2022) berichteten statistischen Kennwerte zeigen, dass die Kultur einen signifikanten Einfluss auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden haben können.

2.2.3 Hypothese 3

In der Forschung gibt es Hinweise darauf, dass die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden geschlechtsabhängig ist. Studien haben gezeigt, dass diese Zusammenhänge unterschiedlich stark ausgeprägt sein können.

Koenig und Al Shohaib (2024) fanden in ihrer Untersuchung eine signifikante Interaktion zwischen Geschlecht und Religiosität in Bezug auf die Lebenszufriedenheit ($B = -.025$, $SE = 0.009$, $p = .007$). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen Religiosität und Lebenszufriedenheit bei Männern stärker ausgeprägt ist als bei Frauen. Ähnliche Trends wurden auch für Glück und Optimismus beobachtet, wobei die Beziehung zwischen allgemeiner Religiosität und Lebenszufriedenheit ($B = .046$, $SE = 0.005$), Glück ($OR = 1.03$, 95% CI [1.02, 1.04]) und Optimismus ($B = .054$, $SE = 0.005$) ebenfalls stärker bei Männern ausgeprägt war (Interaktionseffekt $B = -.025$, $SE = 0.009$, $p = .007$).

Dar und Iqbal (2019) erweiterten diese Erkenntnisse, indem sie die Rolle des Gefühls von Bedeutung als vermittelnden Faktor zwischen religiöser Verpflichtung und Wohlbefinden untersuchten. Ihre Ergebnisse zeigten, dass das Gefühl von Bedeutung eine signifikante vermittelnde Rolle spielt, insbesondere bei Mädchen. Der indirekte Effekt der religiösen Verpflichtung auf das Wohlbefinden über das Gefühl von Bedeutung hatte einen Punktwert von 0,0768 und ein 95%-Konfidenzintervall von 0,0074 bis 0,1675, was auf eine kleine bis mittlere Effektstärke hinweist ($k^2 = 0,068$, 95%-BCa-CI [0.014, 0.160]). Bei der geschlechtsspezifischen Analyse zeigte sich, dass der indirekte Effekt der religiösen Verpflichtung auf das Wohlbefinden bei Mädchen stark und signifikant war (Punktwert = 0,1568, 95%-CI = 0,0527 bis 0,3188), während er bei Jungen schwach und nicht signifikant war (Punktwert = 0,0103, 95%-CI = -0,0848 bis 0,1061).

Basierend auf diesen Erkenntnissen lässt sich feststellen, dass der Einfluss der Religiosität auf das Wohlbefinden durch das Geschlecht moderiert wird. Frauen scheinen besonders von der Unterstützung durch religiöse Gemeinschaften und religiöse Führer zu profitieren, was mit höherer Lebenszufriedenheit verbunden ist. Bei Männern hingegen zeigt sich ein stärkerer Zusammenhang zwischen intrinsischer Religiosität und positiven Gesundheitsaspekten wie Glück und Optimismus.

Die Studie von Lazar und Bjorck (2016) untersuchte die Auswirkungen verschiedener Formen religiöser Unterstützung auf das Wohlbefinden und zeigte, dass Geschlecht eine moderierende Rolle spielt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Unterstützung durch die

religiöse Gemeinschaft stärker mit Lebenszufriedenheit bei Frauen ($\beta = .28, p < .01$) als bei Männern ($\beta = .13, p < .01$) assoziiert war und dass RCS bei Männern stärker negativ mit Angst korreliert war ($\beta = .25, p < .01$) als bei Frauen ($\beta = -.07, ns$). Die Unterstützung durch die religiöse Gemeinschaft lässt sich mit der Dimension der organisierten Religiosität vergleichen, da beide die Teilnahme an gemeinschaftlichen religiösen Praktiken umfasst. Auch ein Geschlechterunterschied bei der intrinsischen Religiosität kann durch die Ergebnisse der Autoren vermutet werden. Intrinsische Religiosität bezieht sich auf die persönliche Motivation und den inneren Glauben einer Person, was der in der Studie von Lazar und Bjorck (2016) gemessenen Unterstützung durch religiöse Führer nahekommt. Die Studie fand heraus, dass Unterstützung durch religiöse Führer insbesondere bei Frauen eine stärkere positive Wirkung auf die Lebenszufriedenheit hatte ($\beta = .20, p < .01$) als bei Männern ($\beta = .09, p < .05$), und dass SLS bei Männern stärker negativ mit Angst korreliert war ($\beta = -.17, p < .01$) als bei Frauen ($\beta = -.04, ns$).

Auf Basis dieser Erkenntnisse lässt sich vermuten, dass Geschlecht den Einfluss der Religiosität auf das Wohlbefinden moderiert.

3 Methoden

In diesem Kapitel wird die empirische Bearbeitung der Hypothesen dargestellt. Zunächst wird die erhobene Stichprobe beschrieben, gefolgt von der Erläuterung der Erhebungsmethode, der Stichprobenauswahl und dem Erhebungsdesign. Darauf folgend wird auf die Operationalisierung der Konstrukte eingegangen. In folgendem Zuge wird die Untersuchungsdurchführung konkretisiert und abschließend wird auf die Auswertungsmethode eingegangen.

3.1 Stichprobenbeschreibung

Von den 506 Probanden, die an der Onlinebefragung teilgenommen haben, mussten 77 entfernt werden, da sie den Fragebogen nicht vollständig oder gewissenhaft beantworteten. Somit nahmen am Onlinefragebogen eine Stichprobe von $N = 429$ Probanden teil. Weibliche Teilnehmer bilden mit $n = 312$ (72.7%) den größten Teil der Gesamtstichprobe ab. Männliche Teilnehmer betrugen mit 26.8% ($n = 115$) den kleineren Teil der Befragten. Des Weiteren gaben 0.5% ($n = 2$) der Probanden an, ein diverses Geschlecht zu haben. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei $M = 48.16$ Jahren ($SD = 0.84$). Eine grafische Darstellung der Altersverteilung ist in Abbildung zu sehen. An ihr lässt sich ablesen, dass der jüngste Teilnehmer 13 Jahre alt war und der älteste Teilnehmer 96 Jahre. Die Verteilung ist bimodal mit einem ersten Gipfel bei 24 und einem zweiten Gipfel bei 58 Jahren. Sie ist nahezu symmetrisch (Schief = -0.07), jedoch flacher als eine Normalverteilung (Kurtosis = -0.68).

3.2 Untersuchungsdesign

Bei dieser Studie handelt sich um ein quantitatives Querschnittstudie mit einer anfallenden Stichprobe, um eine Momentaufnahme des Zusammenhangs zwischen den unterschiedlichen Variablen zu liefern. Die Datengeneration wurde mithilfe eines Onlinefragebogens erstellt, da dadurch eine weitreichendere und ökonomischere Erhebung gewährleistet werden konnte. Auf diese Weise konnten der Interview- und der Versuchsleitereffekt vermieden werden. Der Zugangslink wurde primär über die sozialen Netzwerke verschickt der sich nach dem Prinzip des Schneeballeffekts verbreitete.

Der Fragebogen war auf Deutsch, Englisch und Spanisch verfügbar, um Probanden

mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu erreichen. Um eine gute Durchführung für die Teilnehmer gewährleisten zu können, wurde vor Veröffentlichung des Fragebogens ein Pretest in den drei Sprachen durchgeführt.

Vorraussetzung für die Teilhabe an der Umfrage waren ein internetfähiges Endgerät, ein Mindestalter von 12 Jahren und eine ausreichende Beherrschung mindestens einer der drei Sprachen. Die gewünschte Sprache konnte zu Beginn der Befragung ausgewählt werden.

3.3 Operationalisierung der Konstrukte

Die untersuchten Variablen wurden mithilfe standardisierter Fragebögen erhoben. Die Befragung begann mit zwei Fragebögen zur Religiosität. Die Deutsche Version der Religious Commitment Scale von Klumpparendt und Drenckhan (2014) misst das Engagement einer Person mit ihrer Religion. Neben einer deutschen Version wurde auch eine englische Übersetzung des Fragebogens von den Autoren veröffentlicht. Um ihn für diese Studie nutzen zu können, wurde er zusätzlich auch noch ins Spanische übersetzt. Für diese Übersetzung liegt bislang keine Validierung vor. Da es sich hierbei um eine Sinngemäße Übersetzung handelt, wird die Reliabilität und Validität des originalen Fragebogens herangezogen. Die Faktorladungen der fünf Items auf einen gemeinsamen Faktor liegen bei .81 bis .92. Dies spricht für eine gute Konstruktvalidität und eine gute Reliabilität (Klumpparendt & Drenckhan, 2014). Auf einer siebenstufigen Antwortskala von 0 = *gar nicht* bis 6 = *sehr* konnten die Fragen beantwortet werden. Ein Beispielitem des Fragebogens lautet wie folgt: „Wie ausgeprägt leben Sie nach den Erfordernissen Ihrer Religion oder Ihres Glaubens?“.

Der zweite Fragebogen bezüglich der Religiosität war der Duke University Religion Index (DUREL) von Koenig, Parkerson und Meador (1997). Dieser erhebt drei Subskalen von Religiosität: Organisierte religiöse Aktivitäten (ORA), Nichtorganisierte religiöse Aktivitäten und (NORA) und Intrinsische Religiosität (IR). Das erste Item „Wie oft besuchen Sie die Kirche/Synagoge/Moschee oder andere religiöse Treffen?“ misst auf einer sechsstufigen Skala mit 1 = *Nie*, 2 = *Einmal im Jahr oder weniger*, 3 = *Einige Male im Jahr*, 4 = *Einige Male im Monat*, 5 = *Einmal pro Woche* und 6 = *Mehr als einmal pro Woche* organisierte religiöse Aktivitäten. Auf der gleichen Skala misst das zweite Item „Wie oft widmen Sie sich privaten religiösen Aktivitäten wie Gebet, Meditation oder wie oft setzen Sie sich mit den Schriften Ihrer Religion auseinander?“

nichtorganisierte religiöse Aktivitäten. Die anderen drei Items bilden die dritte Subskala, die die intrinsische Religiosität misst. Hierfür wird eine fünfstufige Antwortskala genutzt, die von 1 = *Stimme überhaupt nicht zu*, 2 = *Stimme wenig zu*, 3 = *Neutral*, 4 = *Stimme etwas zu* bis hin zu 5 = *Stimme vollkommen zu* reicht. Ein Beispiel für solch ein Item ist folgendes: „Meine religiösen Überzeugungen sind das, was wirklich hinter meinem gesamten Lebensansatz steht.“. Die Autoren veröffentlichten eine englische und spanische Version. Für diese Studie wurden die Fragen ins Deutsche übersetzt und die spanische Version wurde überarbeitet. Für die deutsche Übersetzung liegt bislang keine Validierung vor. Da es sich hierbei um eine sinngemäße Übersetzung handelt wird die Reliabilität und Validität des originalen Fragebogens herangezogen. In einer Validierungsstudie von Koenig und Büssing (2010) wurde eine hohe Retestreliabilität (Intra-Klassen-Korrelation = .91) und eine hohe Konsistenz (Cronbachs- α = .78-.91) ermittelt. Der DUREL hat zudem eine hohe konvergente Validität mit anderen Messungen der Religiosität (r = .71-.86).

Im Anschluss erfolgte der WHO-5 Fragebogen zum Wohlbefinden (World Health Organization, 1998), der die Befragten betreffend ihres Wohlbefindenes der letzten zwei Wochen befragte. Das Präfix „In den letzten zwei Wochen...“ leitet die fünf Items, wie beispielsweise „... war ich froh und guter Laune“ ein. Für die Bearbeitung der Items steht eine sechsstufige Skala zur Verfügung, die von 1 = *Die ganze Zeit*, 2 = *Meistens*, 3 = *Etwas mehr als die Hälfte der Zeit*, 4 = *Etwas eniger als die Hälfte der Zeit*, 5 = *Ab und zu* bis 6 = *Zu keinem Zeitpunkt* reicht. Die Reliabilität des WHO-5 wurde in verschiedenen Ländern und kulturellen Kontexten untersucht. Die Ergebnisse einer Validierungsstudie (Sischka, Costa, Steffgen & Schmidt, 2020b) zeigen eine hohe interne Konsistenz (ρ = .83-.93).

Abschließend wurden einige soziodemografischen Daten erhoben. Diese waren das Alter, das Geschlecht, der kulturelle Hintergrund, die potenzielle Religionszugehörigkeit, der aktuelle Beziehungsstatus, der höchste erreichte Bildungsstand, die aktuelle Tätigkeit und in welchem Siedlungstyp die befragte Person wohnt (ländlich oder in der Stadt). Um den kulturellen Hintergrund zu ermitteln, wurden die Probanden gebeten, Angaben zu ihrem aktuellen Wohnort sowie etwaigem Migrationshintergrund bei sich, ihren Eltern oder ihren Großeltern zu machen, einschließlich des Landes, aus dem sie stammen, falls zutreffend. Des Weiteren wurde die Cultural Orientation Scale (COS) von Bierbrauer, Meyer und Wolfradt (2002) genutzt. Der Fragebogen untersucht, ob eine Person aus einer individualistischen oder kollektivistischen Kultur stammt und erfragt die persönliche Meinung bezüglich sozialer Verhaltensweisen in dem Land, zu dem sich die Person zugehörig

fühlt. Beide Subskalen bestehen aus jeweils 13 Items, die mithilfe einer siebenstufigen Antwortskala beantwortet werden. Der ersten Subskala bezüglich der Verbreitung gewisser Sitten und Bräuche steht folgende Antwortoptionen bereit: 1 = *überhaupt nicht*, 2 = *Sehr selten*, 3 = *Selten*, 4 = *Manschmal*, 5 = *Häufig*, 6 = *Sehr häufig* und 7 = *Immer*. Ein Item lautet beispielsweise wie folgt: „Wie häufig richten sich Jugendliche in Deutschland bei der Wahl ihres Freundes oder ihrer Freundin nach den Ratschlägen ihrer Eltern?“. Für die englische und spanische Version wurde die Nationalität entfernt und es wurde nach dem eigenen Land gefragt, da in diesen Fällen keine spezifische Nationalität zugewiesen werden konnte. Im Anweisungstext wurde des Weiteren darauf hingewiesen, dass mit dem „eigenen Land“, jenes gemeint ist, mit dem sich die Person am meisten identifiziert. Aus einer Studie mit unterschiedlichen kulturellen Kontexten ermittelten Bierbrauer et al. (2002) eine gute interne Konsistenz (Cronbachs- $\alpha = .59-.82$) für den Fragebogen. In kulturvergleichenden Studien konnte durch den Fragebogen signifikant zwischen Teilnehmern bezüglich ihrer individualistischen bzw. kollektivistischen Kulturzugehörigkeit differenzieren werden.

3.4 Untersuchungsdurchführung

Die Datenerhebung über erfolgte in dem Zeitraum vom 01.05.2024 bis 02.06.2024. Der mit SoSci-Survey[®] erstellte Fragebogen wurde primär über Messenger-Dienste, wie WhatsApp[®] oder Signal[®], aber auch über das soziale Netzwerke Instagram[®] und über das Portal SurveyCircle[®] mit der Bitte um Weitergabe verbreitet, um eine möglichst große Stichprobe zu erreichen. Die Mindeststichprobengröße von 311 bis 395 Teilnehmern wurde mithilfe des kostenlosen Tools G*Power[®] ermittelt.

Im Einführungstext zu Beginn der Befragung wurde auf die 10 bis 15 minütige Bearbeitungszeit und die garantierte Anonymität der Befragten hingewiesen. Die Teilnehmer wurden zudem darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an der Befragung freiwillig sei. Auf der anschließenden Seite begann die Befragung. Eine inhaltliche Demonstration der genutzten Fragebögen und deren Reihenfolge wurde bereits in Kapitel 3.3 dargeboten. Zu Beginn wurde die eigene Einstellung und das eigene Verhalten im Kontext zu Religiosität befragt, gefolgt von einem kurzen Fragebogen zum psychischen Wohlbefinden. Im Anschluss wurden die Probanden gebeten, einige kurze Angaben zu ihrer Person zu machen. Der inhaltliche Teil endete mit dem Fragebogen bezüglich der kulturellen Orientierung. Auf der letzten Seite wurde den Befragten für ihre Teilnahme gedankt und darauf hingewiesen, dass ihre Daten gespeichert wurden und sie nun das

Browserfenster schließen können.

Potenzielle Störvariablen konnten während der Untersuchungsdurchführung nicht kontrolliert werden. Anhand der Onlinebefragung lag die Entscheidung, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort und unter welchen Bedingungen die Befragung bearbeitet wurde, bei den Teilnehmern selbst.

3.5 Auswertungsmethode

Die Statistik- und Analysesoftware SPSS® wurde für die Berechnungen und statistischen Analysen genutzt. Bevor die Hypothesen jedoch berechnet werden konnten, musste der Datensatz bereinigt werden. Anschließend konnten die Daten ausgewertet werden, beginnend mit den deskriptiven Kennzahlen der drei Konstrukte. Anhand der Lageparameter, der Maße der Streuung und der Verteilung konnten die demographischen Daten der Stichprobe ausgewertet werden. Bei der Cultural Orientation Scale wurden bereits auf SoSci-Survey vier Items umgepolt, damit ein hoher Skalenwert einem hohen Grad der kollektivistischen Orientierung entspricht.

Bei der Prüfung auf Multikollinearität zeigte sich eine starke Korrelation zwischen den vier Religiositätsskalen, was auf Multikollinearität deutet. Damit es nicht zu einer Verzerrung bei der Schätzung der Regressionskoeffizienten kommen konnte und damit ihre Interpretierbarkeit beeinträchtigt wäre, wurde eine explorative Faktornalyse durchgeführt, um die zugrundeliegende Struktur der Daten zu ermitteln und die Anzahl der Faktoren zu bestimmen, die die Varianz in den Subskalen erklären. Die Faktoranalyse identifizierte einen einzigen Faktor, der 89.01% der Gesamtvarianz erklärt. Dieser extrahierte Faktor wurde für die weiteren Untersuchungen verwendet.

Die erste Hypothese wurde mit einer einfachen linearen Regression berechnet. Sie untersuchte inwiefern Religiosität das psychische Wohlbefinden vorhersagen kann. Die Voraussetzungen für eine einfache lineare Regression sind das metrisch-skalierte Kriterium und der mindestens kategorial-skalierte Prädiktor. Des Weiteren wird Linearität zwischen den Variablen und Homoskedastizität vorausgesetzt. Es dürfen keine Autokorrelation und keine Multikollinearität bestehen, um dieses Verfahren durchführen zu können.

Bei der zweiten Hypothese handelte es sich um eine Moderationsanalyse, die mithilfe des Plug-in PROCESS® berechnet wurde. Bei dieser Hypothese wurde untersucht, ob die kulturelle Orientierung den Zusammenhang zwischen Religiosität und psychischem Wohlbefinden moderiert. Die allgemeinen Voraussetzungen für diesen Test sind die Linearität

und der Stichprobenumfang. Des Weiteren gibt es spezifische Voraussetzungen. Eine gegebene Homoskedastizität, keine Autokorrelation und keine Multikollinearität müssen gegeben sein.

Für die dritte Hypothese wurde eine weitere Moderationsanalyse gerechnet. Die Rechnung der H3 diente der Überprüfung des angenommenen geschlechterunterschieds bei der Korrelation der metrischen Religiosität mit dem metrischen Wohlbefinden.

4 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die durchgeführten statistischen Berechnungen dargestellt. Zu Beginn werden die deskriptiven Ergebnisse beschrieben und mit den Normwerten verglichen. Im inferenzstatistischen Unterkapitel wird mit der Prüfung der Vorraussetzung der einzelnen Test mathematisch dargestellt und abschließend werden die Ergebnisse der drei Hypothesen präsentiert. Die ausführliche Interpretation der Ergebnisse geschieht im nachkommenden Kapitel

4.1 Deskriptive Ergebnisse

Die Deutsche Version der Religious Commitment Scale wiesen bei einem $Min = 0$ und einem $Max = 6$ einen Mittelwert von $M = 3.57$ ($SD = 0.10$) und einen Median von $Mdn = 4.00$ auf. Mit den Modi an den Extremen 0 und 6 gemeinsam mit einer Schiefe von -0.39 und Kurtosis von -1.25 ist die Verteilung bimodale, leicht linksschiefe und flacher als eine Normalverteilung.

Die Statistiken der drei Subskalen des DUREL waren wie folgt. ORA wies bei einem $Min = 1$ und einem $Max = 6$ einen Mittelwert von $M = 3.81$ ($SD = 0.09$) und einen Median von $Mdn = 4.00$ auf. Die am häufigsten verteilten Werte lagen bei 6 und bildeten zusammen mit einer Schiefe von -0.16 und einer Kurtosis von -1.46 eine unimodale, leicht linksschiefe und breitgipflige Verteilung. Die Verteilung der NORA Subskalawerte zeigte Mittelwerte von $M = 4.05$ ($SD = 0.10$), einen Median von 5.00 und Modi bei 1 und 6. Die Werte reichten von $Min = 1$ bis $Max = 6$, mit einer Schiefe = -0.41 und Kurtosis = -1.52, das einer bimodalen, leicht linksschiefen und breitgipfligen Verteilung entspricht. Die Werte der IR reichten von $Min = 1$ bis $Max = 5$ und wiesen einen Mittelwert von $M = 3.42$ ($SD = 0.07$) und einen Median von $Mdn = 4.00$ auf. Die am häufigsten verteilten Werte lagen bei 1 und 5 und bildeten zusammen mit einer Schiefe von -0.39 und einer Kurtosis von -1.30 eine bimodale, leicht linksschiefe und breitgipflige Verteilung.

Beim WHO-5 wurde bei einer Range von $Min = 0$ bis $Max = 5$ ein Mittelwert von $M = 3.23$ ($SD = 0.04$) und ein Median von $Mdn = 3.40$ berechnet, bei einer unimodalen (Modus = 4), linksschiefen (Schiefe = -0.88) und leicht spitzköpfigen (Kurtosis = 0.59) Verteilung. Die Werte beinhalteten sechs leichte Ausreißer.

Die COS zeigte einen Mittelwert von $M = 4.59$ ($SD = 0.02$) und einen Median von $Mdn = 4.56$. Der geringste Wert war bei $Min = 2.72$ und der höchste bei $Max = 6.24$.

Eine Schiefe von -0.08 bildet mit einer Kurtosis von 0.57 und einem Modus bei 4.48 eine leicht spitzgipflige unimodale Normalverteilung.

4.2 Inferenzstatistische Ergebnisse

Anschließend erfolgt eine inferenzstatistische Analyse der erhobenen Daten zur Feststellung der Korrelationen zwischen den in Kapitel 2 näher gebrachten Konstrukten Religiosität, Wohlbefinden und Kultur.

4.2.1 Hypothese 1

Die Voraussetzungen für eine Regression, einschließlich Linearität, Normalverteilung der Residuen und Homoskedastizität, wurden erfüllt. Die Linie zur Prüfung auf Linearität durch die Punkte verläuft, zeigte eine gewisse Krümmung, was auf eine mögliche leichte Nichtlinearität hinweisen könnte. Auch die Durbin-Watson-Statistik lag mit 2.01 im gewünschten Bereich und zeigte keine Autokorrelation der Residuen an.

Tabelle 1 demonstriert den signifikanten positiven Einfluss des extrahierten Faktors für Religiosität auf das Wohlbefinden ($R^2 = .05$, $F(1, 427) = 23.1$, $p < .001$). Der Regressionskoeffizient betrug $B = .21$ ($SE = .04$), $t = 4.81$, $p < .001$, mit einem 95% CI [0.12, 0.29]. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass höhere Werte in der Religiosität mit einem höheren psychischen Wohlbefinden assoziiert sind, wobei es sich um einen kleinen bis mittleren Effekt handelt.

Tabelle 1. *Einfache lineare Regression von Religiosität auf psychisches Wohlbefinden*

	B	$SE(B)$	β	t	95% Konfidenzintervall	
					Untere Grenze	Obere Grenze
Konstante	3.23	0.04		75.03	3.14	3.31
Religiosität	0.21	0.04	.23*	4.81	0.12	0.29

Anmerkungen. $N = 429$; Wertebereich der Variable Religiosität -1.69 (*gar nicht religiös*) bis 1.16 (*sehr religiös*).

* $p < .001$

4.2.2 Hypothese 2

Um die vermutete Moderation der kulturellen Orientierung auf den Zusammenhang zwischen der Religiosität und dem psychischen Wohlbefinden zu testen, wurde eine Moderationsanalyse durchgeführt. Die Voraussetzungen für diese, einschließlich Linearität, Homoskedastizität und mit $N = 418$ eine Normalverteilung der Residuen, wurden erfüllt. Die Linie zur Prüfung auf Linearität durch die Punkte verläuft, zeigte eine gewisse Krümmung, was auf eine mögliche leichte Nichtlinearität hinweisen könnte. Die Durbin-Watson-Statistik lag mit 2.00 im gewünschten Bereich und zeigte keine Autokorrelation der Residuen an. Zwischen den Variablen herrschte keine Multikollinearität, wie die Toleranzwerten von 0.80 verdeutlichen.

Tabelle 2. *Moderationsanalyse Religiosität und kulturelle Orientierung auf das psychische Wohlbefinden*

	B	$SE(B)$	t	p	ΔR^2
Konstante	2.24	0.45	4.95	< .001	
Religiosität	-0.47	0.41	-1.15	.250	
Kultur	0.21	0.10	2.16	.032	
Interaktionsterm	0.14	0.09	1.56	.119	.006
R^2					.063*

Anmerkungen. $N = 418$; Wertebereich der Variable Religiosität -1.69 (*gar nicht religiös*) bis 1.16 (*sehr religiös*); kulturelle Orientierung 1 (*überhaupt nicht*) bis 7 (*immer*).

* $p < .001$

Eine Moderationsanalyse wurde durchgeführt, um zu bestimmen, ob die Interaktion zwischen der kulturellen Orientierung und der Religiosität das psychische Wohlbefinden signifikant vorhersagt. Das Gesamtmodell war, wie in Tabelle 2 demonstriert, signifikant, $F(3, 414) = 10.44$, $p < .001$, mit einer Varianzaufklärung von 6.31%. Die Ergebnisse konnten jedoch keinen Moderationseffekt von Kultur auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden finden, $\Delta R^2 = 0.61\%$, $F(1, 414) = 2.44$, $p = .119$, 95% CI[-0.04, 0.31]. Gemäß den Empfehlungen von Hayes (2018) wurde der Interaktionsterm aus dem Modell entfernt, was zu einem neuen Modell mit Haupteffekten führte (siehe Tabelle refHaupteffekte). Dieses neue Modell zeigte, dass sowohl Religiosität ($B = 0.15$, $p = .002$) als auch Kultur ($B = 0.20$, $p = .038$) signifikant mit dem Wohlbefinden zusammenhängen. Dabe handelte es

sich jedoch nur um kleine, aber signifikante Einflüsse der Variablen auf das Wohlbefinden (Religiosität $\beta = .17$; Kultur $\beta = .11$).

Tabelle 3. *Modell mit Haupteffekten*

	B	$SE(B)$	β	t	p
Religiosität	0.15	0.05	.17	3.15	.002
Kultur	0.20	0.10	.11	2.09	.038

Anmerkungen. $N = 418$; Wertebereich der Variable Religiosität -1.69 (*gar nicht religiös*) bis 1.16 (*sehr religiös*); kulturelle Orientierung 1 (*überhaupt nicht*) bis 7 (*immer*).

4.2.3 Hypothese 3

Um die vermutete Moderation des biologischen Geschlechts auf den Zusammenhang zwischen Religiosität und dem psychischen Wohlbefinden zu testen, wurde eine Moderationsanalyse durchgeführt. Dafür wurden die zwei diversen Fälle ausgeschlossen. Die Voraussetzungen für die Moderationsanalyse, einschließlich Linearität, Homoskedastizität und mit $N = 427$ eine Normalverteilung der Residuen, wurden erfüllt. Die Linie zur Prüfung auf Linearität durch die Punkte verläuft, zeigte eine gewisse Krümmung, was auf eine mögliche leichte Nichtlinearität hinweisen könnte. Dennoch ist das Muster nicht extrem, sodass das Verhältnis der Variablen bei visueller Inspektion des Streudiagramms mit LOESS-Glättung etwa linear ist. Die Durbin-Watson-Statistik lag mit 1.98 im gewünschten Bereich und zeigte keine Autokorrelation der Residuen an. Zwischen den Variablen herrschte keine Multikollinearität, wie die Toleranzwerten von 0.93 verdeutlichen.

Eine Moderationsanalyse wurde durchgeführt, um zu bestimmen, ob die Interaktion zwischen dem biologischen Geschlecht und Religiosität das psychische Wohlbefinden signifikant vorhersagt. Das Gesamtmodell war, wie in Tabelle 4 demonstriert, signifikant, $F(3, 423) = 9.20$, $p < .01$, mit einer Varianzaufklärung von 6.93%. Die Ergebnisse zeigten zudem einen Moderationseffekt des Geschlechts auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden, $\Delta R^2 = 1.02\%$, $F(1, 423) = 4.64$, $p = .03$, 95% CI[0.02, 0.42]. Dieser Effekt kann als klein eingestuft werden, was darauf hindeutet, dass das Geschlecht einen geringen, aber signifikanten Einfluss auf die Beziehung zwischen Religiosität und Wohlbefinden hat.

Tabelle 4. *Moderationsanalyse Religiosität und biologisches Geschlecht auf das psychische Wohlbefinden*

	<i>B</i>	<i>SE(B)</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	ΔR^2
Konstante	3.39	0.17	19.54	< .001	
Religiosität	-0.15	0.18	-0.83	.406	
Geschlecht	-0.11	0.10	-1.15	.251	
Interaktionsterm	0.22	0.10	2.15	.032	.010*
R^2					.069**

Anmerkungen. $N = 427$; Wertebereich der Variable Religiosität -1.69 (*gar nicht religiös*) bis 1.16 (*sehr religiös*); biologisches Geschlecht 1 (*männlich*) bis 2 (*weiblich*).

* $p < .05$, ** $p < .001$

4.3 Explorative Ergebnisse

Zusätzlich zu den untersuchten Hypothesen wurden noch weitere explorative Untersuchungen getätigt. Es wurde entdeckt, sich die Religiosität unter den Befragten unterscheidet abhängig davon, ob sie einen Migrationshintergrund besitzen oder nicht. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass gewisse Religionen kollektivistischer eingestellt waren, als es die stark individualistischen europäischen Herkunftsländer annehmen lassen.

Zur Berechnung der Gruppenunterschiede wurde ein ungepaarter t-Test berechnet. Neben der Unabhängigkeit der Messungen besitzen die abhängige Variablen das mindestens erforderliche intervallskalierte Skalenniveaus und die unabhängige Variable die notwendige Nominalskalierung mit zwei Ausprägungen. Des Weiteren befanden sich im Datensatz keine Ausreißer und die Varianzen in den Gruppen waren gleich. Gemäß dem Shapiro-Wilk Test waren beide Gruppen nicht normalverteilt ($p < .001$), aufgrund der Stichprobengröße kann jedoch von einer Normalverteilung der Daten ausgegangen werden.

Die Ergebnisse zeigten einen statistisch signifikanten Unterschied gemäß der Religiosität der Probanden zwischen jenen, die seit mindestens drei Generationen im gleichen Land leben und jenen, die einen Migrationshintergrund besitzen. Personen, die aus einem anderen Land stammen ($n = 102$, $M = 0.19$, $SD = 0.96$) wiesen einen höheren Wert an Religiosität auf, als die Einheimischen ($n = 327$, $M = -0.06$, $SD = 1.00$), $t(427) = 2.23$, $p = .026$, 95% CI [0.03, 0.47]. Die Effektgröße, gemessen durch Cohen's d , beträgt 0.25, was auf einen kleinen bis mittleren Effekt hinweist.

Es wurde zudem untersucht, wie sich die Religionsgruppen hinsichtlich ihrer kulturellen Orientierung unterscheiden. Dafür wurde eine ANOVA gerechnet, die die Voraussetzungen der unabhängigen Messung, das mindestens intervallskalierte Kriterium und die Nominalskalierung des Prädiktors erfüllte. Mit dem Shapiro-Wilk Test wurde auf die Normalverteilung des Prädiktors und dessen Gruppen geprüft. Die kulturelle Orientierung war normalverteilt für fast alle Religionen, nicht aber für das Katholische Christentum, wie eine Überprüfung mit dem Shapiro-Wilk Test ergab ($\alpha_{i.05}$). Da die einfaktorielle ANOVA relativ robust gegenüber Verletzungen ist, wurden keine Gegenmaßnahmen durchgeführt (Schmider, Ziegler, Dana & Beyer, 2010). Unter den Befragten befanden sich sechs leichte Ausreißer (siehe Anhang). Die Überprüfung der Varianzhomogenität erfolgte mit dem Levene-Test, gemäß dem Homoskedastizität angenommen werden kann ($p > .05$). Um post-hoc Analysen durchführen zu können, wurde der einzige buddhistische Datensatz ausgeschlossen.

Die Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVA zeigen, dass sich die kulturelle Orientierung statistisch signifikant zwischen den Religionen unterschied, $F(9, 407) = 9.22$, $p < .001$, $\eta^2 = .17$. Dies entspricht einem großen Effekt.

Die Tukey HSD-Tests zeigten, wie in Tabelle 5 ersichtlich, signifikante Unterschiede in den Kulturwerten zwischen den Religionen. Die Katholiken ($n = 296$) wiesen signifikant höhere kollektivistische Werte auf als die Protestanten ($n = 24$) und nicht religiöse Personen ($n = 46$). Hindus ($n = 7$) zeigten die höchsten kollektivistischen Werte, die signifikant höher waren als die Werte von Orthodoxen ($n = 7$), Protestanten, Freikirchlern ($n = 8$), Atheisten ($n = 12$) und nicht religiöse Personen.

Tabelle 5. *Tukey HSD Post-hoc Tests für kulturelle Orientierung nach Religion*

Vergleich	Mittelwertsdifferenz	Std. Fehler	p	95% Konfidenzintervall	
				Untere Grenze	Obere Grenze
Katholizismus vs. Protestantismus	0.50	0.10	<.001	0.18	0.81
Katholizismus vs. Nicht religiös	0.46	0.07	<.001	0.22	0.70
Hinduismus vs. Protestantismus	0.95	0.20	<.001	0.31	1.59
Hinduismus vs. Freikirchlich	0.90	0.24	0.009	0.13	1.68
Hinduismus vs. Atheismus	0.85	0.22	0.007	0.14	1.56
Hinduismus vs. Nicht religiös	0.92	0.19	<.001	0.31	1.52

Anmerkungen. Die Tabelle zeigt die Mittelwertsdifferenzen, Standardfehler, p -Werte und 95% Konfidenzintervalle der signifikanten Tukey HSD-Tests für die kulturelle Orientierung nach Religion.

Literaturverzeichnis

- Allolio-Näcke, L. & Demmrich, S. (2022). Religion und Religiosität. In U. Wolfradt, L. Allolio-Näcke & P. S. Ruppel (Hrsg.), *Kulturpsychologie: Eine Einführung* (S. 377–386). Wiesbaden: Springer.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York, NY: W.H. Freeman und Company.
- Bierbrauer, G., Meyer, H. & Wolfradt, U. (2002). COS. Cultural Orientation Scale [Verfahrensdokumentation und Fragebogen auf Deutsch, Englisch, Russisch und Spanisch]. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), *Open Test Archive*. Trier: Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID).
- Borrell-Carrió, F., Suchman, A. L. & Epstein, R. M. (2004). The biopsychosocial model 25 years later: Principles, practice, and scientific inquiry. *Annals of Family Medicine*, 2(6), 576–582. doi:<https://doi.org/10.1370/afm.245>
- Bowker, J. (2003). *The Concise Oxford Dictionary of World Religions*. Oxford University Press.
- Büssing, A. (2008). Spiritualität – inhaltliche Bestimmung und Messbarkeit. *Prävention*, 31(2), 35–37.
- Carver, C. S. (2010). Resilience and thriving: Issues, models, and linkages. *Journal of Social Issues*, 54(2), 245–266. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1998.tb01217.x>
- Cohen, A. B. (2015). Religion's Profound Influences on Psychology: Morality, Intergroup Relations, Self-Construal, and Enculturation. *Current Directions in Psychological Science*, 24(1), 77–82. doi:<https://doi.org/10.1177/0963721414553265>
- Croucher, S. M., Zeng, C., Rahmani, D. & Sommer, M. (2017, Januar). Religion, Culture, and Communication. doi:<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.166>
- Dar, K. A. & Iqbal, N. (2019). Religious Commitment and Well-Being in College Students: Examining Conditional Indirect Effects of Meaning in Life. *Journal of Religion and Health*, 58, 2288–2297. doi:<https://doi.org/10.1007/s10943-017-0538-2>
- Das, K. V., Jones-Harrell, C., Fan, Y., Ramaswami, A., Orlove, B. & Botchwey, N. (2020). Understanding subjective well-being: perspectives from psychology and public health. *Public Health Reviews*, 42(25). doi:<https://doi.org/10.1186/s40985-020-00142-5>
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of goal pursuits. Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. doi:https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

- Dhanabhakyaam, M. & Sarath, M. (2023). Psychological Wellbeing: A systematic Literature Review. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*, 3(1), 603–607. doi:<https://doi.org/10.48175/IJARSCT-8345>
- Diener, E., Oishi, S. & Lucas, R. E. (2009). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and Life Satisfaction. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Hrsg.), *The Oxford Handbook of Positive Psychology*. doi:<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195187243.013.0017>
- Diener, E., Suh, E., Lucas, R. & Smith, H. L. (1999). Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. *Psychological Bulletin*, 125(2).
- Durkheim, E. (1915). Definition of Religious Phenomena and of Religion. In *The Elementary Forms of the Religious Life* (S. 47). London: George Allen & Unwin LTD.
- Durkheim, E. (1981). *Die elementare Formen des religiösen Lebens* (L. Schmidts, Übers.). Frankfurt am Main: Verlag der Weltreligionen.
- Engel, G. L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*, 196(4286), 129–136. doi:<https://doi.org/10.1126/science.847460>
- European Union. (2021). 7.2% of people in the EU suffer from chronic depression. Verfügbar unter <https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20210910-1>
- Fernández, M. B. & Rosell, J. (2022). An Analysis of the Relationship Between Religiosity and Psychological Well-Being in Chilean Older People Using Structural Equation Modeling. *Journal of Religion and Health*, 61, 1585–1604. doi:<https://doi.org/10.1007/s10943-021-01442-z>
- Graham, C. & Crown, S. (2014). Religion and wellbeing around the world: Social purpose, social time, or social insurance? *International Journal of Wellbeing*, 4(1), 1–27. doi:<https://doi.org/10.5502/ijw.v4i1.1>
- Griffiths, P. J. (2000). The Very Idea of Religion. *First Things*, (103), 30–35.
- Hardy, S. A., Nelson, J. M., Moore, J. P. & King, P. E. (2019). Processes of Religious and Spiritual Influence in Adolescence: A Systematic Review of 30 Years of Research. *Journal of research on adolescence : the official journal of the Society for Research on Adolescence*, 29(2), 254–275. doi:<https://doi.org/10.1111/jora.12486>
- Hayes, A. F. (2018). *Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis, Second Edition: Methodology in the Social Sciences* (2nd ed.). Guildford Press.
- Hemel, U. (2023). Der Einfluss der Religionen auf die Frauengesundheit. In J. Wacker, C. Rothe & M. En-Nosse (Hrsg.), *Globale Frauengesundheit: Gynäkologie und*

- Geburtshilfe unter unterschiedlichen globalen Bedingungen* (S. 71–82). doi:https://doi.org/10.1007/978-3-662-66081-2_6
- Hernandez, M. & Gibb, J. K. (2019). Culture, behavior and health. *Evolution, Medicine, and Public Health*, 2020(1), 12–13. doi:<https://doi.org/10.1093/emph/eoz036>
- Hewlett, B. S. & Hewlett, B. L. (2008). Outbreak Control. In J. A. Young (Hrsg.), *Ebola, Culture and Politics: The Anthropology of an Emerging Disease* (S. 111–130). CA: Wadsworth Cengage Learning.
- Hoffmann, R. (1984). Erleben von Glück - eine empirische Untersuchung. *Psychologische Beiträge*, 26(3), 516–532.
- Hofstede, G. (2001). Individualism and Collectivism. In *Culture's consequences. Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations* (2. Aufl.). Thousand Oaks: Sage.
- Hofstede, G. (2024). The 6-D model of national culture. Verfügbar unter <https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/>
- Hoogeveen, S., Sarafoglou, A., Aczel, B., Aditya, Y., Alayan, A. J., Allen, P. J., ... Wagenmakers, E.-J. (2022). A many-analysts approach to the relation between religiosity and well-being. *Religion, Brain & Behavior*, 13(3), 237–283. doi:<https://doi.org/10.1080/2153599X.2022.2070255>
- Hornberg, C. (2016). Gesundheit und Wohlbefinden. In U. Gebhard & T. Kistemann (Hrsg.), *Landschaft, Identität und Gesundheit: Zum Konzept der Therapeutischen Landschaften* (S. 63–69). doi:https://doi.org/10.1007/978-3-531-19723-4_5
- Izard, C. E. (1994). Freude: Eine Einführung in die Grundlagen der Emotionspsychologie (B. Murakami, Übers.). In, *Die Emotionen des Menschen* (3. Auflage, S. 271–312). Beltz, Psychologie-Verlags-Union.
- Jakobs, M. (2018). Religion und Gesundheit aus religionspsychologischer Perspektive - und was dies für die Religionspädagogik bedeutet. *Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik*, 17(1), 83–100. doi:<https://doi.org/10.23770/tw0048>
- Jokela, M. (2022). Religiosity, Psychological Distress, and Well-Being: Evaluating Familial Confounding With Multicohort Sibling Data. *American Journal of Epidemiology*, 191(4), 584–590. doi:<https://doi.org/10.1093/aje/kwab276>
- Joseph, R. (2011). Evolution of Paleolithic Cosmology and Spiritual Consciousness, and the Temporal and Frontal Lobes. *Journal of Cosmology*, 14, 4400.

- Karasz, A., Gany, F., Escobar, J., Flores, C., Prasad, L., Inman, A., ... Diwan, S. (2019). Mental Health and Stress Among South Asians. *Journal of Immigrant Minority Health*, 21(Suppl 1), 7–14. doi:<https://doi.org/10.1007/s10903-016-0501-4>
- Kiecolt-Glaser, J. K., McGuire, L., Robles, T. F. & Glaser, R. (2002). Emotions, morbidity, and mortality: New perspectives from psychoneuroimmunology. *Annual Review of Psychology*, 53, 83–107. doi:<https://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135217>
- Klumparendt, A. & Drenckhan, I. (2014). *Deutsche Version der Religious Commitment Scale*. Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS). doi:<https://doi.org/10.6102/zis217>
- Knecht, J. (2020). Kulturdimensionen nach Hofstede - kurz zusammengefasst. Verfügbar unter <https://praxistipps.focus.de/kulturdimensionen-nach-hofstede-kurz-zusammengefasst.124852>
- Koenig, H. G. (2010). Spirituality and mental health. *International Journal of Applied Psychoanalytic Studies*, 7, 116–122. doi:<https://doi.org/10.1002/aps.239>
- Koenig, H. G. (2012). Religion, spirituality, and health: The research and clinical implications. *International Scholarly Research Network Psychiatry*, 1–33. doi:<https://doi.org/10.5402/2012/278730>
- Koenig, H. G. & Al Shohaib, S. (2024). Religious involvement and psychological well-being in the Middle East. *The International Journal of Psychiatry in Medicine*, 59(3), 341–359. doi:<https://doi.org/10.1177/00912174231197548>
- Koenig, H. G. & Büssing, A. (2010). The Duke University Religion Index (DUREL): A Five-Item Measure for Use in Epidemiological Studies. *Religion*, 1, 78–85. doi:<https://doi.org/10.3390/rel1010078>
- Koenig, H. G., Parkerson, G. R. & Meador, K. G. (1997). Religion index for psychiatric research. *The American Journal of Psychiatry*, 154(6), 885–886. doi:<https://doi.org/10.1176/ajp.154.6.885b>
- Koenig, H. G., VanderWeele, T. J. & Peteet, J. R. (2024, Januar). 3C1Definitions. In *Handbook of Religion and Health*. Oxford University Press.
- Köhrsen, J. (2024). Religion und Ökologie. In M. Sonnberger, A. Bleicher & M. Groß (Hrsg.), *Handbuch Umweltsoziologie* (S. 477–489). doi:https://doi.org/10.1007/978-3-658-37218-7_48
- Krause, C. (2015). Spirituelle und religiöse Praktiken – Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden. In *Mit dem Glauben Berge versetzen? Psychologische Erkenntnisse zur Spiritualität* (S. 131–144). doi:https://doi.org/10.1007/978-3-662-48457-9_7

- Lazar, A. & Bjoreck, L. P. (2016). Religious support and psychological well-being: gender differences among religious Jewish Israelis. *Mental Health, Religion & Culture*, 19(4), 393–407. doi:<https://doi.org/10.1080/13674676.2016.1207160>
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. *European Journal of Personality*, 1(3), 141–169. doi:<https://doi.org/10.1002/per.2410010304>
- Lucas, R. E. (2016). Subjective Well-Being in Psychology. In M. D. Adler & M. Fleurbaey (Hrsg.), *The Oxford Handbook of Well-Being and Public Policy*. doi:<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199325818.013.13>
- Maly-Motta, H. (2023). Subjektives Wohlbefinden. In *Gestersste Eltern* (S. 13–15). doi:<https://doi.org/10.1007/978-3-658-41224-1>
- Matsumoto, D. & Juang, L. (2016). *Culture and psychology* (6th). Belmont, CA: Cengage Learning.
- Mayring, P. (1991). Die Erfassung subjektiven Wohlbefindens. In A. Abele & P. Becker (Hrsg.), *Wohlbefinden. Theorie, Empirie, Diagnostik* (S. 51–71). Weinheim: Juventa.
- McGlichey, S., Waters, R. & Scheinpflug, C. (2023). Religion and Culture - Difference and Similarity. In S. McGlinchey (Hrsg.), *International Relations* (S. 9.3.1). E-International Relations.
- Monroe, M. W., Spicer, R., Canlas, G. M., Chilcott, T., Christopher, S., Daniels, M., ... Slingerland, E. (2023). On the Category of Religion: A Taxonomic Analysis of a Large-Scale Database. *Journal of the American Academy of Religion*, 91(2), 257–282. doi:<https://doi.org/10.1093/jaarel/lfad065>
- Nelson, S. K., Kushlev, K. & Lyubomirsky, S. (2014). The pains and pleasures of parenting: When, why, and how is parenthood associated with more or less well-being? *Psychological Bulletin*, 140(3), 846–895. doi:<https://doi.org/10.1037/a0035444>
- Ng, J. Y. Y., Ntoumaniy, N., Thøgersen-Ntoumani, C., Deci, E. L., Ryan, R. M., Duda, J. L. & Williams, G. C. (2012). Self-Determination Theory Applied to Health Contexts: A Meta-Analysis. *Perspectives on Psychological Science*, 7(4), 325–340. doi:<https://doi.org/10.1177/1745691612447309>
- Norenzayan, A. & Shariff, A. F. (2008). The Origin and Evolution of Religious Prosociality. *Science*, 322(5898), 58–62.
- Pargament, K. I. (1997). *The psychology of religion and coping: Theory, research, practice*. New York, NY: Guilford Press.

- Pearlin, L. I. (2010). The Life Course and the Stress Process: Some Conceptual Comparison. *The Journal of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 65B(2), 207–215. doi:<https://doi.org/10.1093/geronb/gbp106>
- Pew Research Center. (2019). Religion's Relationship to Happiness, Civic Engagement and Health Around the World: In the U.S. and other countries, participation in a congregation is a key factor. Verfügbar unter <https://www.pewresearch.org/religion/2019/01/31/religions-relationship-to-happiness-civic-engagement-and-health-around-the-world/>
- Pew Research Center. (2022). Key Findings From the Global Religious Futures Project. Verfügbar unter <https://www.pewresearch.org/religion/2022/12/21/key-findings-from-the-global-religious-futures-project/>
- Röhrle, B. (2023). Wohlbefinden / Well-Being. In *Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden*. doi:<https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i134-1.0>
- Sapolsky, R. M. (2004). *Why zebras don't get ulcers: The acclaimed guide to stress, stress-related diseases, and coping*. New York, NY: Henry Holt und Company.
- Schmider, E., Ziegler, M., Dana, E. & Beyer, L. (2010). Is it really robust? *Methodology European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences*, 6(4). doi:<https://doi.org/10.1027/1614-2241/a000016>
- Schneider, G. & Toyka-Seid, C. (2024). Religion. Verfügbar unter <https://www.bpb.de/kurzknapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/321041/religion/>
- Sischka, P. E., Costa, A. P., Steffgen, G. & Schmidt, A. F. (2020a). The WHO-5 well-being index – validation based on item response theory and the analysis of measurement invariance across 35 countries. *Journal of Affective Disorders Reports*, 1, 100020. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jadr.2020.100020>
- Sischka, P. E., Costa, A. P., Steffgen, G. & Schmidt, A. F. (2020b). The WHO-5 well-being index – validation based on item response theory and the analysis of measurement invariance across 35 countries. *Journal of Affective Disorders Reports*, 1, 100020. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jadr.2020.100020>
- Tay, L., Li, M., Myers, D. & Diener, E. (2014). Religiosity and subjective well-being: An international perspectiv. In C. Kim-Prieto (Hrsg.), *Religion and Spirituality Across Cultures. Cross-Cultural Advancements in Positive Psychology* (S. 163–175). doi:https://doi.org/10.1007/978-94-017-8950-9_9

- The Britannica Dictionary. (2024). religion. Verfügbar unter <https://www.britannica.com/dictionary/religion>
- Triandis, H. C. (1994). *Culture and social behavior*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Trojan, A. & Legewie, H. (2001). *Nachhaltige Gesundheit und Entwicklung: Leitbilder, Politik und Praxis der Gestaltung gesundheitsförderlicher Umwelt- und Lebensbedingungen*. Frankfurt: Verlag für Akademische Schriften.
- Uchino, B. N. (2006). Social support and health: A review of physiological processes potentially underlying links to disease outcomes. *Journal of Behavioral Medicine*, 29(4), 377–387. doi:<https://doi.org/10.1007/s10865-006-9056-5>
- Utler, A. (2020). Kultur, Kulturdimensionen und Kulturstandards. In T. Ringeisen, P. Genkova & F. T. L. Leong (Hrsg.), *Handbuch Stress und Kultur: Interkulturelle und kulturvergleichende Perspektiven* (S. 1–17). doi:https://doi.org/10.1007/978-3-658-27825-0_3-1
- Van Cappellen, P., Toth-Gauthier, M., Saroglou, V. & Fredrickson, B. L. (2016). Religion and Well-Being: The Mediating Role of Positive Emotions. *Journal of Happiness Studies*, 17, 485–505. doi:<https://doi.org/10.1007/s10902-014-9605-5>
- Weltgesundheitsorganisation Regionalbüro für Europa. (2024). Kulturelle Kontexte von Gesundheit und Wohlbefinden. Verfügbar unter <https://who-sandbox.squiz.cloud/de/health-topics/health-determinants/behavioural-and-cultural-insights-for-health/cultural-contexts-of-health-and-well-being>
- Wielga, J. & Knospe, T. (2023). *Kulturelle und soziale Faktoren der Gesundheitskompetenz: Ein erster explorativer Ansatz* (Research Report Nr. 03/2023). Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik (IAT). doi:<https://doi.org/10.53190/fa/202303%0A>
- Wilczewski, M., Wang, R., Du, R., Søderberg, A., Giuri, P., Mughan, T., ... Jacob, M. J. (2023). Cultural novelty and international students' experience: a five-country study. *Higher Education*, 86, 1107–1128.
- World Health Organization. (1948). *Constitution of the World Health Organization*. World Health Organization.
- World Health Organization. (1998). WHO (Five) Well-being Index. Verfügbar unter <https://www.psykiatri-regionh.dk/who-5/who-5-questionnaires/Pages/default.aspx>
- World Population Review. (2024). Religion by Country 2024. Verfügbar unter <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/religion-by-country>

Zurlo, G. A. (2021). Religions in Europe: A Statistical Summary. In G. Davie & L. N. Leustean (Hrsg.), *The Oxford Handbook of Religion and Europe* (S. 793–798). doi:<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198834267.005.0001>